

KONTRIBUSI TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN STATUS GIZI BALITA

Rina Nur Hidayati
Faisal Ibnu

KONTRIBUSI TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN STATUS GIZI BALITA

Penulis:

Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.

Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Kontribusi Tugas Kesehatan Keluarga Dalam Meningkatkan Status Gizi Balita

Penulis: Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom.
Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syauckani

ISBN: 978-634-7139-02-3

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

EDISI

PUBLIKASI

DESKRIPSI FISIK

IDENTIFIKASI

SUBJEK

KLASIFIKASI

PERPUSNAS ID

Kontribusi tugas kesehatan keluarga dalam meningkatkan status gizi balita / penulis, Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom., Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.

Cetakan Pertama, Februari 2025

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

vi, 84 halaman ; 30 cm

ISBN 978-634-7139-02-3

Gizi anak -- Nutrisi -- Perawatan kesehatan anak

362.176 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1186986>

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan buku ini. Penulisan buku ini adalah sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan wujud nyata karya penulis yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul **"Kontribusi Tugas Kesehatan Keluarga Dalam Meningkatkan Status Gizi Balita"**.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi balita. Gizi berkontribusi lebih dari sepertiga dari semua kematian pada balita di dunia. Gizi kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh anak terhadap serangan penyakit dan membuat penyakit lebih parah. Kekurangan gizi yang dialami balita akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita hingga dewasa dan bersifat irreversible.

Peran perawat komunitas diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai pada keluarga. Penanaman nilai-nilai pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui tugas kesehatan keluarga dengan pendekatan model *Family Centered Nursing* (FCN). Pemahaman keluarga tentang pelaksanaan tugas kesehatan keluarga sangat diperlukan agar keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi balita secara tepat. Optimalisasi tugas kesehatan keluarga dengan pendekatan model *Family Centered Nursing* (FCN) menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan status gizi balita.

Buku yang berjudul **"Kontribusi Tugas Kesehatan Keluarga Dalam Meningkatkan Status Gizi Balita"** ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para dosen pengajar, mahasiswa maupun masyarakat luas sebagai bahan acuan dasar dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dalam asuhan keperawatan keluarga terutama pada balita

dengan masalah gizi. Pendekatan keluarga ini dapat dijadikan acuan pengembangan model dalam meningkatkan status gizi balita.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi dan membantu penulis, sehingga buku ini dapat tersusun. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu keperawatan keluarga dan komunitas, pelayanan kesehatan di masyarakat serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP BALITA	7
A. Pengertian Balita	7
B. Balita Sebagai Kelompok At Risk	8
C. Pertumbuhan dan Perkembangan Balita	11
D. Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Balita	13
BAB 3 STATUS GIZI BALITA.....	15
A. Pengertian Status Gizi	15
B. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita	15
C. Penilaian Status Gizi Balita	22
D. Kebutuhan Gizi Balita	29
E. Gizi Seimbang Untuk Balita.....	40
F. Pesan Gizi seimbang.....	42
BAB 4 TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN GIZI BALITA.....	47
A. Pengertian Keluarga	47
B. Peran dan Fungsi Keluarga	48
C. Tugas Kesehatan Keluarga	53
D. Konsep Model Family Centered Nursing	57

E. Pengaruh Tugas Kesehatan Keluarga Terhadap Status Gizi Balita Dengan Pendekatan Model Family Centered Nursing	61
--	----

BAB 5 PENUTUP	65
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	75
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	81
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Masa balita adalah masa yang sulit, menarik, dan penting dalam periode kehidupan. Sistem tubuh terjadi maturasi secara bertahap pada masa balita. Sejak anak dalam kandungan hingga anak berusia 3 tahun merupakan masa emas untuk tumbuh kembang fisik, mental dan sosial. Pada masa ini terjadi pertumbuhan otak secara berkelanjutan hingga 80% dan peningkatan ketrampilan intelektual (Kemenkes RI, 2020; Potts, N. L., & Mandleco, 2012). Setelah anak lahir, pertumbuhan otak akan dicapai 75% pada usia 3 tahun, dan 90% pada usia 6 tahun. Setelah itu pertumbuhan otak melambat sampai pada usia dewasa. Maturasi otak memberi fondasi untuk perkembangan bahasa, belajar dan perilaku. Masa balita membutuhkan nutrisi dari berbagai sumber dan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Balita belum mampu mengonsumsi atau mencerna makanan yang tersedia dan mereka cenderung mengalami masalah gizi (malnutrisi) karena kebutuhan akan zat gizi yang sangat tinggi (Hockenberry M, Wilson D, 2016).

Pemahaman keluarga tentang pelaksanaan tugas kesehatan keluarga sangat diperlukan agar keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi balita secara tepat. Kemandirian keluarga berorientasi pada tugas kesehatan keluarga dalam mengatasi masalah gizi meliputi: 1) mengenal masalah: apa yang keluarga ketahui tentang gizi, triguna makanan dan manfaatnya, penyebab dan tanda-tanda masalah gizi, 2) mengambil keputusan: menurut keluarga apa akibat masalah gizi bila tidak seimbang, apakah menurut keluarga sangat

penting melakukan penanggulangan masalah gizi, 3) kemampuan memberikan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan: apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah gizi, bagaimana cara memilih, mengolah dan menyimpan makanan, apakah keluarga mengetahui alternatif perawatan anggota dengan masalah gizi, hambatan apa dalam penanggulangan masalah gizi di rumah, 4) kemampuan memodifikasi lingkungan: bagaimana keluarga mengatur lingkungan (fisik, psikologis, sosial) yang dapat menunjang keberhasilan penanggulangan masalah gizi, 5) kemampuan memanfaatkan fasilitas kesehatan: apa saja yang diperoleh di Polindes/Pustu/Puskesmas/Rumah Sakit, adakah hambatan yang dihadapi untuk memanfaatkan sarana/fasilitas kesehatan, bagaimana keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan (Hidayati, 2011; Kemenkes, 2006, 2010).

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi balita (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2024). Gizi berkontribusi lebih dari sepertiga dari semua kematian pada balita di dunia. Gizi kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh anak terhadap serangan penyakit dan membuat penyakit lebih parah. UNICEF melaporkan status gizi balita pada tahun 2022 sebanyak (22,3%) diantaranya mengalami stunting, 13,7 juta anak mengalami gizi kurang, dan 5,6 % anak mengalami overweight atau kegemukan. Pada tahun 2022, diperkirakan terdapat 45 juta balita (6,8 persen) terkena dampak gizi kurang, dimana 13,6 juta (2,1 persen) menderita gizi buruk. Lebih dari tiga perempat (75%) dari seluruh anak dengan gizi buruk tinggal di Asia dan 22% lainnya tinggal di Afrika (UNICEF et al., 2023). Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita pendek di Indonesia (36%) tertinggi 4 dari beberapa negara seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%),

Thailand (16%), dan Singapura (4%) sesuai dengan populasi anak tiap negara yang berbeda (Apriluana & Fikawati, 2018).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, terdapat 17,7% balita masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita kurang gizi sebanyak 13,8% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 mengemukakan bahwa angka stunting di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 21,6% dimana pada tahun 2021 sebanyak 24,4. Pada tahun 2022 angka stunting di Indonesia mengalami penurunan 2,8%, sedangkan target penurunan angka stunting di Indonesia 14% pada tahun 2024, sehingga perlu penurunan 3,8% untuk mencapai target yang diinginkan. Sedangkan balita dengan status gizi kurang dengan badan pendek meningkat sebanyak 7,7% dimana pada tahun 2022 peningkatan pada balita dengan gizi kurang sebanyak 0,6% dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 7,1% (SSGI, 2023). Pencapaian tersebut belum mampu mencapai target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk pembangunan berkelanjutan kedua yang mengakhiri segalanya bentuk malnutrisi pada tahun 2030 (Susanto, T., Yunanto, R. A., Rasny, H. & L. S., dan Nur, 2019).

Hasil penelitian (Suhardin et al., 2024) yang menyatakan bahwa banyak keluarga yang tidak menyadari masalah stunting, banyak yang mengaitkannya dengan masalah tersebut faktor genetik. Upaya penanganan stunting pada anak hendaknya difokuskan pada peran orang tua dalam pertumbuhan perkembangan anak dan pengetahuan gizi (Putri & Rong, 2021; Vaughn et al., 2016). Hasil penelitian (Hastuti et al., 2024) menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan ibu dalam memenuhi gizi setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga pada keluarga dengan anak stunting usia 6-24 bulan

yaitu penyiapan dan pengolahan makanan ($p = 0.000$), pemberian makanan pendamping ASI ($p = 0.000$), dan pemberian makanan responsif ($p = 0.000$). Penyelenggaraan fungsi keluarga harus dioptimalkan untuk meningkatkan gizi status balita (Febrianti et al., 2022).

Kekurangan gizi yang dialami balita akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita hingga dewasa dan bersifat irreversible (Sir et al., 2021). Gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk, dan meningkatkan risiko penyakit infeksi, dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular (penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi dan *stroke*), diabetes serta kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Lebih separuh dari semua kematian di Indonesia merupakan akibat penyakit tidak menular (Kemenkes, 2014b).

Gangguan status gizi pada balita akan berdampak pada balita yaitu dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Akibat buruk dari gangguan gizi jangka panjang adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, *stroke*, dan disabilitas pada usia tua (Kemenkes, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan status gizi balita setelah diberikan intervensi tugas kesehatan keluarga. Tugas kesehatan keluarga efektif meningkatkan status gizi balita ($P < 0.025$). Hasil penelitian tersebut menunjukkan pada kelompok intervensi setelah dilaksanakan tugas kesehatan keluarga terjadi peningkatan status gizi dengan berat badan normal sebanyak 5,3%. Optimalisasi tugas kesehatan keluarga dengan pendekatan

model *Family Centered Nursing* (FCN) menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan status gizi balita (Hidayati RN, Ibnu F, 2025).

Peran perawat komunitas diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai pada keluarga meliputi pemilihan makanan, aktifitas, dan pilihan gaya hidup sehat sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah gizi pada balita. Penanaman nilai-nilai pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui tugas kesehatan keluarga dalam asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan model *Family Centered Nursing* (FCN) (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010; Hidayati, 2011).

BAB 2

KONSEP BALITA

A. Pengertian Balita

Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Masa ini sangat penting dalam proses tumbuh kembangnya sehingga disebut *golden period* yang di mana proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat cepat baik secara fisik, psikologis, mental dan sosialnya. Balita sebagai fase perkembangan anak yang sangat tidak berdaya melawan suatu penyakit, salah satu masalah dari penyakit tersebut adalah akibat dari kekurangan/kelebihan asupan gizi (Kemenkes, 2014a). Anak balita merupakan anak yang menginjak umur diatas 1 tahun atau lebih terkenal dengan anak usia dibawah 5 tahun (Septiari, 2012).

Sedangkan (Hockenberry M, Wilson D, 2016) membagi periode perkembangan usia menjadi lima kelompok usia yaitu periode prenatal yaitu dari konsepsi sampai dengan kelahiran, periode bayi (*infancy period*) yaitu usia 0-12 bulan atau 18 bulan, anak awal (*early childhood*) yaitu usia 1-6 tahun, anak pertengahan (*middle childhood/school age*) yaitu usia 6-11 atau 12 tahun, dan anak akhir (*later childhood*) yaitu usia 11-19 tahun. Pada periode anak awal (*early childhood*) terbagi 2 yaitu bawah tiga tahun (*toddler*) yaitu usia 1-3 tahun, dan pra sekolah (*pre school*) yaitu usia 3- 5 tahun atau 6 tahun.

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan

perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi, balita termasuk kelompok yang rawan gizi serta mudah menderita kelainan gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Konsumsi makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak sehingga konsumsi makanan berpengaruh besar terhadap status gizi anak untuk mencapai pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak (Ariani, 2017).

B. Balita Sebagai Kelompok At Risk

Balita merupakan kelompok risiko (At Risk). Kelompok risiko adalah sekumpulan orang yang memiliki kecenderungan mengalami gangguan kesehatan dan dapat berkembang dikarenakan ada factor penyebabnya (Allender, Rector, 2010). Faktor risiko akan meningkatkan kemungkinan perkembangan penyakit atau masalah kesehatan. Kelompok balita dikategorikan dalam risiko tinggi karena beberapa dalam beberapa faktor, yaitu risiko biologi, risiko sosial ekonomi dan risiko ketersediaan makanan (Hitchcock, Schubert, 2003). Sedangkan Stanhope menyatakan faktor risiko meliputi usia dan biologi, lingkungan dan gaya hidup (Stanhope, 2016).

Risiko biologi masalah gizi pada balita terkait dengan faktor usia. Usia balita yang terlalu muda, ketergantungan pada orang lain dalam ketersediaan makanan, kelahiran prematur dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), sistem imun dan sistem pencernaan yang masih imatur mempunyai peluang lebih besar terhadap risiko penyakit dan masalah gizi (Hitchcock, Schubert, 2003). Faktor risiko yaitu usia, usia 0-5 tahun merupakan kelompok umur yang berisiko terhadap masalah nutrisi dikarenakan pemasukan

yang tidak seimbang (Allender, Rector, 2010). Faktor biologi yaitu genetik merupakan salah satu penyebab terjadinya gizi lebih (Hitchcock, Schubert, 2003; Kaakinen & Melissa, 2018). Faktor genetik merupakan bekal dasar dan memiliki kedudukan pertama untuk memperoleh hasil akhir proses tumbuh kembang anak (Soetjiningsih, 2016).

Masa balita membutuhkan nutrisi dari berbagai sumber dan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Balita belum mampu mengonsumsi atau mencerna makanan yang tersedia dan mereka cenderung mengalami malnutrisi karena kebutuhan akan zat gizi yang sangat tinggi (Hockenberry M, Wilson D, 2016).

Risiko sosial ekonomi: risiko tinggi kurangnya nutrisi dalam dihubungkan dengan risiko ekonomi yaitu faktor kemiskinan. Penduduk miskin mempunyai resiko lebih besar untuk timbul permasalahan kesehatan. Ketidakmampuan keluarga terhadap sumber daya finansial akan berdampak tidak terpenuhi kebutuhan pokok kehidupan harian keluarga, dengan demikian permasalahan kesehatan akan mudah timbul pada balita (Stanhope & Lancaster, 2014). Status sosial ekonomi sebagai salah satu faktor yang terbesar yang mempengaruhi kesehatan nutrisi. Risiko tinggi kurangnya nutrisi pada balita disebabkan karena faktor risiko sosial ekonomi khususnya kemiskinan. Anak yang miskin dihubungkan dengan faktor ketersediaan makanan, keterbatasan akses makanan, faktor orang tua karena pendidikan yang kurang, pilihan gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya informasi dan akses. Prevelensi gizi kurang mayoritas pada kelompok sosial ekonomi yang kurang disebabkan kurangnya variasi makanan (Hitchcock, Schubert, 2003). Anak yang hidup dalam kemiskinan mengalami nutrisi

kurang sampai dengan buruk (Allender, Rector, 2010; Hitchcock, Schubert, 2003).

Risiko ketersediaan makanan: nutrisi di masyarakat dipengaruhi oleh keamanan makanan dan peraturan pemerintah. Keamanan makanan mengarah kepada kebebasan penyakit, investasi dan kontaminasi. Badan pemerintah bertanggung jawab terhadap pengawasan setiap aspek dari produksi makanan, namun masih ditemukan *outbreak escherichia coli* dan infeksi *salmonella* pada saat tertentu. Balita dengan gangguan atau kurang berkembangnya sistem imun memudahkan untuk mengalami penyakit akibat bawaan makanan (*foodborne disease*). Keluhan yang dirasakan akibat kontaminasi makanan atau minuman (produk susu) antara lain sakit perut, diare, muntah-muntah dan kelemahan (Hitchcock, Schubert, 2003)

Faktor gaya hidup, dimana keluarga merupakan unit dasar dalam berperilaku meliputi nilai kesehatan, kebiasaan hidup dan persepsi. Perilaku hidup sehat sangat dipengaruhi oleh keluarga seperti konsumsi makan yang sehat. Gaya hidup juga dapat mempengaruhi kesehatan anggota keluarga lainnya. Bila salah satu anggota keluarga berinisiatif merubah perilaku, anggota keluarga yang lain juga akan melakukan perubahan. Keluarga juga menjadi role model pada anggota keluarga lainnya secara positif dan negatif (Kaakinen & Melissa, 2018). Masalah gizi terus merebak menjadi beban ganda. Dalam suatu rumah tangga, misalnya tidak hanya terdapat masalah kekurangan gizi, tetapi sekaligus masalah kegemukan. Keduanya disebabkan oleh asupan makanan yang salah atau tidak seimbang. Kekurangan gizi akibat serba kurang sedangkan kelebihan gizi akibat makan serba lebih dari kebutuhan (Kemenkes,

2014b). Masalah gizi meningkat di kalangan populasi karena akses makanan yang mudah yaitu adanya peningkatan konsumsi makanan cepat saji (*fast food*). Selain harganya yang jauh lebih mahal, makanan cepat saji mengandung zat-zat yang tinggi lemak, kolesterol, dan sodium dan rendah vitamin A, biotin, folat dan zat besi (Hitchcock, Schubert, 2003).

C. Pertumbuhan dan Perkembangan Balita

Pertumbuhan merupakan peningkatan jumlah dan ukuran sel pada saat membelah diri dan mensintesis protein baru; menghasilkan peningkatan ukuran dan berat seluruh atau sebagian bagian sel. Sedangkan perkembangan yaitu serangkaian keterampilan dan kompetensi yang harus dicapai atau dikuasainya pada setiap tahap perkembangan agar anak mampu berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya (Hockenberry M, Wilson D, 2016).

Pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik. Pada usia 0-6 bulan, berat bayi bertambah 682 gram per bulan. Berat badan lahir bayi meningkat dua kali lipat ketika usia 5 bulan. Antara usia 6-12 bulan berat bayi bertambah 341 gram per bulan. Berat lahir bayi meningkat tiga kali lipat saat berusia 12 bulan. Berat badan akan menjadi empat kali berat badan lahir pada umur 2 tahun. Pada masa pra sekolah kenaikan berat badan rata-rata 2 kg/tahun (Adriana, 2013).

Pertumbuhan tinggi badan rata-rata pada waktu lahir adalah 50 cm. Tinggi badan anak 1 tahun $1,5 \times$ TB lahir, 4 tahun $2 \times$ TB lahir dan 6 tahun $1,5 \times$ TB lahir. Pada umur 6 bulan lingkaran kepala rata-rata adalah 44 cm, umur 1 tahun 47 cm, umur 2 tahun 49 cm, dan dewasa 54 cm (Adriana, 2013).

Freud mengemukakan perkembangan psikososial anak dibagi dalam beberapa tahap atau fase, yaitu: a). Fase oral (0-

11 bulan): selama masa bayi, sumber kesenangan anak berpusat pada aktifitas oral : mengisap, mengigit, mengunyah, dan mengucapkan serta ketergantungan yang sangat tinggi dan selalu minta dilindungi untuk mendapatkan rasa aman. Masalah yang diperoleh pada tahap ini adalah menyapih dan makan. b). Fase anal (1-3 tahun): kehidupan anak berpusat pada kesenangan anak terhadap dirinya sendiri, sangat egoistik, mulai mempelajari struktur tubuhnya. Pada fase ini tugas yang dapat dilaksanakan anak adalah latihan kebersihan. Toilet training adalah waktu yang tepat dilakukan dalam periode ini. Masalah yang dapat diperoleh pada tahap ini adalah bersifat obsesif (gangguan pikiran) dan bersifat impulsif yaitu dorongan membuka diri, tidak rapi, kurang pengendalian diri. c). Fase phalik/oedipal (3-6 tahun): kehidupan anak berpusat pada genetalia dan area tubuh yang sensitif. Anak mulai suka pada lain jenis. Anak mulai mempelajari adanya perbedaan jenis kelamin. Anak mulai memahami identitas gender, anak sering meniru ibu atau bapak dalam berpakaian maupun berpenampilan (Hurlock, 2011).

Erickson mengemukakan perkembangan psikososial tergantung pada bagaimana individu menyelesaikan tugas perkembangannya pada tahap itu, yang paling penting adalah bagaimana memfokuskan diri individu pada penyelesaian konflik yang baik itu berlawanan atau tidak dengan tugas perkembangannya. Perkembangan psikososial: a). *Trust vs. Miss trust* (0-1 tahun): Kebutuhan rasa aman dan ketidakberdayaannya menyebabkan konflik basic trust dan misstrust, bila anak mendapatkan rasa amannya maka anak akan mengembangkan kepercayaan diri terhadap lingkungannya, ibu sangat berperan penting. b). *Autonomy vs shame and doubt* (2-3 tahun): Organ tubuh

lebih matang dan terkoordinasi dengan baik sehingga terjadi peningkatan keterampilan motorik, anak perlu dukungan, pujian, pengakuan, perhatian serta dorongan sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap dirinya, sebaliknya celaan hanya akan membuat anak bertindak dan berfikir ragu-ragu. Kedua orang tua objek sosial terdekat dengan anak. *c). Iniatif vs guilty* (3-6 tahun): Bila tahap sebelumnya anak mengembangkan rasa percaya diri dan mandiri, anak akan mengembangkan kemampuan berinisiatif yaitu perasaan bebas untuk melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Bila tahap sebelumnya yang dikembangkan adalah sikap ragu-ragu, maka ia akan selalu merasa bersalah dan tidak berani mengambil tindakan atas kehendak sendiri (Hurlock, 2011).

D. Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang Balita

Secara umum terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan (Soetjiningsih, 2016).

Faktor genetik merupakan bekal dasar dan memiliki kedudukan pertama untuk memperoleh hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Pertumbuhan ditandai oleh kekuatan atau ketangguhan dan kecepatan atau kecekapan pembelahan, status sensitivitas jaringan yang akan rangsangan, umur pubertas, dan berakhirnya pertumbuhan tulang. Faktor bawaan yang normal dan patologik, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa merupakan faktor genetik (Soetjiningsih, 2016).

Faktor lingkungan merupakan komponen yang sangat memastikan berhasil tidaknya potensi atau kemampuan genetik. Lingkungan yang baik atau bermutu akan memungkinkan tercapainya potensi genetik, sedangkan

lingkungan yang tidak baik akan menghambatnya. Lingkungan ini merupakan lingkungan bio,psikososial yang mempengaruhi seseorang setiap hari, sejak dari konsepsi sampai ujung jiwanya. Faktor lingkungan pasca natal yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang terdiri dari: a). Lingkungan biologis terdiri dari ras/suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kerentanan terhadap penyakit, kondisi kesehatan kronis, fungsi metabolisme dan hormon. b). Faktor fisik terdiri dari cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, dan radiasi. c). Faktor psikososial terdiri dari stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman yang wajar, kelompok sebaya, stress, sekolah, cinta dan kasih sayang, dan kualitas interaksi anak dan orang tua. d. Faktor adat dan istiadat terdiri dari pekerjaan dan pendapatan keluarga, Pendidikan ayah dan ibu, jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga, stabilitas rumah tangga, kepribadian ibu dan ayah, pola pengasuhan, adat istiadat, norma dan tabu, agama, urbanisasi, dan kehidupan politik (Soetjiningsih, 2016). Kurangnya air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memadai serta praktek- praktek kebersihan yang buruk adalah beberapa mendasari penyebab malnutrisi, penyakit dan kematian pada anak-anak (UNICEF., 2023).

BAB 3

STATUS GIZI BALITA

A. Pengertian Status Gizi

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang di konsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Supariasa IDN, Bakri N, 2020).

Status gizi merupakan gambaran ukuran pemenuhan kebutuhan gizi yang diperoleh dari asupan dan pemanfaatan zat gizi oleh tubuh. Status gizi didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik/klinis, pengukuran data antropometri, hasil uji biokimia, dan riwayat gizi (Nassar, 2015).

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Setiap individu membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda antara individu, hal ini tergantung pada usia orang tersebut, jenis kelamin, aktifitas tubuh dalam sehari, berat badan dan lain-lain (Supariasa IDN, Bakri N, 2020).

B. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi meliputi karakteristik individu anak (penyebab langsung) yaitu infeksi dan asupan makanan tidak seimbang; penyebab tidak

langsung meliputi tidak cukup pangan/kurangnya akses, kurangnya perawatan keluarga dan sanitasi atau pelayanan kesehatan yang kurang; penyebab dasar/utama meliputi kurangnya kualitas dan kuantitas SDM (pendidikan yang kurang), dan status ekonomi yang kurang (UNICEF., 2023). Faktor yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi status gizi sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan

Penilaian konsumsi pangan rumah tangga atau secara perorangan merupakan cara pengamatan langsung yang dapat menggambarkan pola konsumsi penduduk menurut daerah, golongan sosial ekonomi dan sosial budaya. Konsumsi pangan lebih sering digunakan sebagai salah satu teknik untuk memajukan tingkat keadaan gizi. Penyebab masalah gizi yang pokok di tempat paling sedikit dua pertiga dunia adalah kurang cukupnya pangan untuk pertumbuhan normal, kesehatan dan kegiatan normal. Kurang cukupnya pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan dalam keluarga. Tidak tersedianya pangan dalam keluarga yang terjadi terus menerus akan menyebabkan terjadinya penyakit kurang gizi. Gizi kurang merupakan keadaan yang tidak sehat karena tidak cukup makan dalam jangka waktu tertentu. Kurangnya jumlah makanan yang dikonsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas dapat menurunkan status gizi. Apabila status gizi tidak cukup maka daya tahan tubuh seseorang akan melemah dan mudah terserang infeksi (Soekirman, 2012).

Salah satu penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita adalah karena gangguan atau masalah makan. Permulaan masa menyapih merupakan awal dari suatu perubahan besar baik pada balita. Gizi kurang bisa

terjadi pada usia bayi karena masa peralihan antara saat disapih dan mulai mengikuti pola makanan orang dewasa atau karena keluarga/pengasuh mengikuti pola makan keliru dalam memberikan asupan makanan pada balita. Perkembangan mental anak dapat dilihat dari kemampuannya mengatakan “tidak” terhadap makanan yang ditawarkan. Kebanyakan anak hanya mau makan satu jenis makanan selama berminggu-minggu atau *food-jag* (Arisman., 2014)

2. Infeksi

Penyakit infeksi dan keadaan gizi anak merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dengan infeksi, nafsu makan anak mulai menurun dan mengurangi konsumsi makanannya, sehingga berakibat berkurangnya zat gizi ke dalam tubuh anak. Dampak infeksi yang lain adalah muntah dan mengakibatkan kehilangan zat gizi. Infeksi yang menyebabkan diare pada anak dapat mengakibatkan cairan dan zat gizi di dalam tubuh berkurang. Terkadang orang tua juga melakukan pembatasan makan akibat infeksi yang diderita sehingga menyebabkan asupan zat gizi sangat kurang sekali bahkan bila berlanjut lama dapat mengakibatkan terjadinya gizi buruk (Soekirman, 2012). Status kesehatan berhubungan gizi balita. Gizi kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh anak terhadap serangan penyakit dan membuat penyakit lebih parah. Lebih dari sepertiga dari anak-anak meninggal akibat pneumonia, diare dan penyakit lainnya dikarenakan kurang gizi (UNICEF., 2023).

Terjadi hubungan timbal balik antara kejadian penyakit infeksi dan gizi buruk. Anak yang menderita gizi buruk akan mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga anak rentan terhadap penyakit infeksi. Disisi lain

anak yang menderita sakit infeksi akan cenderung menderita gizi buruk (Kemenkes RI, 2020).

Masalah gizi disebabkan oleh pola makan dan perawatan yang kurang, dan diperburuk oleh penyakit. Anak-anak yang bertahan hidup mungkin menjadi terkunci dalam siklus penyakit yang berulang dan goyah pertumbuhannya. Gizi kurang mengurangi kesehatan fisik, merusak perkembangan dan kemampuan kognitif mereka yang tidak dapat diubah lagi, dan pada akhirnya merusak kapasitas mereka sebagai orang dewasa (UNICEF., 2023).

3. Pendidikan/Pengetahuan Gizi

Pendidikan secara tidak langsung mempengaruhi status gizi pada balita karena berhubungan dengan berkurangnya pendapatan, rendahnya tingkat pengetahuan dan status pekerjaan. Kurangnya informasi pada keluarga tentang nutrisi dan bagaimana mengatur nutrisi dengan gizi seimbang untuk balita dapat menyebabkan kebiasaan makan anak yang tidak sehat (Hitchcock, Schubert, 2003)

Unsur pendidikan erat hubungannya dengan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Pendidikan ibu pada umumnya masih rendah. Meskipun mereka memiliki keuangan yang cukup, tetapi tidak mempunyai pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Pengetahuan tentang kesehatan dan gizi merupakan syarat penting bagi ibu agar dapat menerapkan pola makan dengan gizi seimbang pada anaknya (Soekirman, 2012).

Unsur pendidikan perempuan berpengaruh pada kualitas pengasuhan anak. Suatu studi "*positive deviance*" mengungkapkan anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, apalagi ibunya berpendidikan,

mengerti soal pentingnya ASI, manfaat posyandu dan kebersihan, meskipun sama-sama miskin, ternyata anaknya lebih sehat. Sebaliknya sebagian anak yang gizi buruk ternyata diasuh oleh nenek atau pengasuh yang juga miskin dan tidak berpendidikan (Kemenkes RI, 2020).

Pengetahuan tentang gizi adalah kepandaian memilih makanan yang merupakan sumber zat-zat gizi dan kepandaian dalam mengolah bahan makanan. Status gizi yang baik penting bagi kesehatan setiap orang, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anaknya. Pengetahuan gizi memegang peranan yang sangat penting dalam penggunaan dan pemilihan bahan makanan dengan baik sehingga dapat mencapai keadaan gizi yang seimbang (Soekirman, 2012).

4. Higiene Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan yang buruk akan menyebabkan anak lebih mudah terserang penyakit infeksi yang akhirnya dapat mempengaruhi status gizi. Sanitasi lingkungan sangat terkait dengan ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, jenis lantai rumah serta kebersihan peralatan makan pada setiap keluarga. Semakin tersedia air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, maka semakin kecil risiko anak terkena penyakit kurang gizi (Soekirman, 2012)

Penilaian konsumsi pangan rumah tangga atau secara perorangan merupakan cara pengamatan langsung yang dapat menggambarkan pola konsumsi penduduk menurut daerah, golongan sosial ekonomi dan sosial budaya. Konsumsi pangan lebih sering digunakan sebagai salah satu teknik untuk memajukan tingkat keadaan gizi. Penyebab masalah gizi yang pokok di tempat paling sedikit dua pertiga dunia adalah kurang

cukupya pangan untuk pertumbuhan normal, kesehatan dan kegiatan normal. Kurang cukupnya pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan dalam keluarga. Tidak tersedianya pangan dalam keluarga yang terjadi terus menerus akan menyebabkan terjadinya penyakit kurang gizi. Gizi kurang merupakan keadaan yang tidak sehat karena tidak cukup makan dalam jangka waktu tertentu. Kurangnya jumlah makanan yang dikonsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas dapat menurunkan status gizi. Apabila status gizi tidak cukup maka daya tahan tubuh seseorang akan melemah dan mudah terserang infeksi (Soekirman, 2012).

5. Tugas Kesehatan Keluarga

Pada penyebab tidak langsung masalah gizi adalah kurangnya perawatan keluarga. Keluarga berperan mengajarkan dan membantu balita makan makanan bervariasi dengan gizi seimbang, mengatur jadwal makan balita, membatasi asupan gula, memotivasi balita dengan aktifitas-aktifitas yang melibatkan banyak gerakan, membantu hygiene gigi, dan mengontrol berat badan balita agar seimbang. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

Tugas kesehatan keluarga (kemandirian keluarga) meliputi menerima petugas, menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan, tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar, memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran, melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai anjuran, melakukan tindakan pencegahan aktif, dan melakukan tindakan peningkatan (promotif) secara aktif

(Kemenkes, 2006).

Keluarga merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi status gizi balita. Keluarga harus berpartisipasi aktif dalam memantau status gizi balita. Oleh karena itu, Penyelenggaraan fungsi keluarga dalam lingkungan keluarga besar harus dioptimalkan untuk meningkatkan gizi status balita (Febrianti et al., 2022). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayati, 2011) diperoleh bahwa tugas kesehatan keluarga yang baik (keluarga mandiri III & IV) 81,9% memiliki balita dengan status gizi baik, dibandingkan dengan keluarga yang dengan tugas kesehatan keluarga kurang (keluarga mandiri I & II) 72,7 % memiliki balita dengan status gizi baik.

6. Sosial Ekonomi

Status ekonomi keluarga adalah pendapatan keluarga dari beberapa sumber pendapatan. Kurangnya ekonomi pada keluarga dapat berdampak pada kesehatan, yaitu kurangnya perawatan diri, peningkatan keterbatasan aktifitas, peningkatan terjadinya penyakit kronis, dan peningkatan ketidakmampuan (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010). Kemampuan ekonomi keluarga berpengaruh terhadap biaya perawatan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan, kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan, transportasi, rekreasi, dan perumahan (Stanhope, 2016).

Status ekonomi adalah salah satu faktor yang terbesar yang mempengaruhi status gizi khususnya kemiskinan (Hitchcock, Schubert, 2003). Kemiskinan ini paling sering didefinisikan sebagai penghasilan yang cukup hanya untuk membeli barang dan jasa. Pendapatan keluarga mempunyai efek yang signifikan terhadap

kesejahteraan pada masa balita. Anak yang miskin lebih tinggi risiko fisik, sosial dan efek emosional dalam kehidupannya. Kekurangan dalam status gizi anak dihubungkan dengan kemiskinan (Potts, N. L., & Mandelco, 2012). Pencegahan gizi kurang dan gizi buruk sulit karena menyangkut ekonomi yang kurang dari keluarga (kemiskinan). Kemiskinan menyebabkan orang tua tidak bisa memberikan makanan sehat yang bergizi seimbang (Soekirman, 2012).

C. Penilaian Status Gizi Balita

Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki risiko status gizi kurang maupun gizi lebih. Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu : penilaian langsung dan penilaian tidak langsung.

Penilaian Langsung dilakukan melalui antropometri, pemeriksaan klinis, biokimia, biofisik. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan biokimia digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi, dimana dilakukan pemeriksaan dalam suatu bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif terhadap deplesi, uji ini disebut uji biokimia statis. Pemeriksaan biofisik

merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti kejadian buta senja (Supariasa IDN, Bakri N, 2020).

Penilaian tidak langsung dilakukan melalui survei konsumsi makanan, vital statistik, faktor ekologi. Survei konsumsi makanan merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga. Vital statistik merupakan salah satu metode penilaian status gizi melalui data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, seperti angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, statistik pelayanan kesehatan, dan angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kekurangan gizi. Penilaian berdasarkan faktor ekologi digunakan untuk mengetahui penyebab malnutrisi berguna untuk melakukan intervensi gizi (Supariasa IDN, Bakri N, 2020).

Standar antropometri anak digunakan untuk menetapkan acuan dalam penilaian status gizi dan tren pertumbuhan Anak Indonesia, sebagai rujukan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko gagal tumbuh tanpa menunggu sampai anak menderita masalah gizi, serta sebagai dasar untuk mendukung kebijakan kesehatan dan dukungan publik terkait dengan pencegahan gangguan pertumbuhan. Standar Antropometri Anak digunakan untuk menilai atau menentukan status gizi anak. Penilaian status gizi Anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak. Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO *Child Growth Standards* untuk anak

usia 0-5 tahun dan *The WHO Reference 2007* untuk anak 5-18 tahun (Kemenkes, 2020).

Umur yang digunakan pada standar ini merupakan umur yang dihitung dalam bulan penuh, sebagai contoh bila umur anak 2 bulan 29 hari maka dihitung sebagai umur 2 bulan. Indeks Panjang Badan (PB) digunakan pada anak umur 0-24 bulan yang diukur dengan posisi terlentang. Bila anak umur 0-24 bulan diukur dengan posisi berdiri, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm. Sementara untuk indeks Tinggi Badan (TB) digunakan pada anak umur di atas 24 bulan yang diukur dengan posisi berdiri. Bila anak umur di atas 24 bulan diukur dengan posisi terlentang, maka hasil pengukurannya dikoreksi dengan mengurangi 0,7 cm (Kemenkes, 2020).

Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) atau sangat pendek (*severely stunted*), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia (Kemenkes, 2020).

Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (*possible risk of overweight*). Kondisi gizi buruk biasanya

disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis) (Kemenkes, 2020).

Kategori dan ambang batas status gizi anak dalam pengukuran status gizi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak usia 0-60 bulan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategori Dan Ambang Batas Status Gizi Balita

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Severely underweight	< -3 SD
	Berat badan normal	-3 SD s.d <-2 SD
	Underweight	-2 SD s.d +1SD
	Resiko berat badan lebih	> +1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/PB atau TB/PB atau TB/PB)	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi2	> +3 SD

BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD

Keterangan:

1. Anak yang termasuk pada kategori ini mungkin memiliki masalah pertumbuhan, perlu dikonfirmasi dengan BB/TB atau IMT/U
2. Anak pada kategori ini termasuk sangat tinggi dan biasanya tidak menjadi masalah kecuali kemungkinan adanya gangguan endokrin seperti tumor yang memproduksi hormon pertumbuhan. Rujuk ke dokter spesialis anak jika diduga mengalami gangguan endokrin (misalnya anak yang sangat tinggi menurut umurnya sedangkan tinggi orang tua normal) (Kemenkes, 2020).

Dalam rangka pencegahan masalah gizi pada anak, harus dilakukan deteksi dini di masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) antara lain posyandu, poskesdes, dan institusi pendidikan. Jika ditemukan risiko gagal tumbuh (*at risk failure to thrive*), kenaikan massa lemak tubuh dini (*early adiposity rebound*) dan risiko perawakan pendek (*short stature*) maka wajib segera dilakukan tata laksana sesuai kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Deteksi dini melalui UKBM misalnya posyandu, dimulai dari pemantauan pertumbuhan dengan menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Hasil penimbangan berat badan di Posyandu, harus diplot pada grafik BB/U dalam Buku KIA atau KMS, bila ditemukan:

1. Anak dengan kriteria nilai Zscore BB/U di bawah minus dua standar deviasi atau di atas satu standar deviasi (<-2

- SD atau $> +1$ SD) maka perlu dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan:
- a. penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U
 - b. penilaian tren IMT/U pada anak dengan BB/U $> +1$ SD (anak $> 7-8$ bulan)
2. Anak dengan kriteria nilai Z-score BB/U di antara minus dua standar deviasi sampai dengan kurang dari sama dengan satu standar deviasi ($-2 \leq \text{BB/U} \leq +1$) termasuk anak yang normal, namun perlu dilihat tren pertumbuhannya.
- a. Bila tren mengikuti garis pertumbuhan (Naik), maka anak dapat kembali ke Posyandu untuk dipantau pertumbuhannya pada bulan
 - b. Bila anak tidak ditimbang bulan sebelumnya atau tren tidak mengikuti garis pertumbuhan (Tidak Naik), maka anak perlu di konfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan:
 - 1) Penilaian kenaikan berat badan dibandingkan dengan standar *weight increment* (khusus untuk anak 0-24 bulan)
 - 2) Penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U
 - 3) Jika di Posyandu terdapat sumber daya untuk melakukan pengukuran panjang badan atau tinggi badan, maka hasil pengukuran harus diplot pada grafik PB/U atau TB/U.
3. Anak dengan kriteria PB/U atau TB/U berada di antara minus dua standar deviasi sampai dengan 3 standar deviasi ($> +3$ SD atau > -2 SD) termasuk anak dengan kategori tinggi badan normal, namun perlu dilihat tren pertumbuhannya.

- a. Bila tren mengikuti garis pertumbuhan (Naik), maka anak dapat kembali ke Posyandu untuk dipantau pertumbuhannya pada bulan berikutnya.
- b. Bila anak tidak diukur bulan sebelumnya atau tren tidak mengikuti garis pertumbuhan (Tidak Naik), maka anak perlu di konfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan:
 - 1) penilaian kenaikan panjang atau tinggi badan dibandingkan dengan standar *length/height increment* (khusus untuk anak 0-24 bulan)
 - 2) penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U
4. Anak dengan kriteria nilai Zscore PB/U atau TB/U dibawah minus dua standar deviasi atau diatas tiga standar deviasi (< -2 SD atau $> +3$ SD) perlu dikonfirmasi oleh petugas kesehatan yang berkompeten untuk dilakukan penilaian status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U atau TB/U, BB/PB dan atau BB/TB, IMT/U.

Penilaian status gizi perlu melihat seluruh indeks antropometri agar dapat diketahui masalah yang sesungguhnya untuk tata laksana segera.

1. Anak 0-24 bulan dengan kenaikan berat badan kurang dari standar *weight increment* berisiko mengalami gagal tumbuh. Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan evaluasi lengkap melalui Proses Asuhan Gizi dan dilakukan pemeriksaan untuk kemungkinan adanya penyakit penyerta atau dirujuk.
2. Anak dengan BB/PB atau BB/TB di bawah minus dua atau di bawah minus tiga standar deviasi termasuk gizi kurang atau gizi buruk sehingga wajib mendapatkan intervensi berupa pencegahan dan tatalaksana gizi buruk pada balita atau dirujuk.

3. Anak dengan IMT/U lebih dari satu standar deviasi ($> +1$ SD) atau anak usia lebih dari 7-8 bulan dengan tren IMT meningkat berisiko mengalami kenaikan lemak tubuh dini (*early adiposity rebound*). Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan intervensi pencegahan dan tatalaksana gizi lebih pada balita atau dirujuk.
4. Anak 0-24 bulan dengan kenaikan panjang badan kurang dari standar *length increment* berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan linear. Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan evaluasi lengkap melalui Proses Asuhan Gizi dan dilakukan pemeriksaan untuk kemungkinan adanya penyakit penyerta atau dirujuk.
5. Anak dengan PB/U atau TB/U dibawah minus dua standar deviasi ($< -2SD$) adalah anak dengan perawakan pendek (*short stature*). Anak ini wajib ditindaklanjuti dengan tatalaksana *stunting* dan dirujuk. Pada anak dengan PB/U atau TB/U terletak di atas tiga standar deviasi ($> +3$ SD), artinya anak berperawakan tinggi dan perlu dirujuk ke fasyankes yang lebih tinggi untuk deteksi dini penyebabnya sehingga dapat ditatalaksana segera (misalnya anak yang sangat tinggi menurut umurnya sedangkan tinggi orang tua normal) (Kemenkes, 2020).

D. Kebutuhan Gizi Balita

Pedoman Gizi Seimbang yang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1955 merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1992. Pedoman tersebut menggantikan slogan "4 Sehat 5 Sempurna" yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952 namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang

dihadapi. Diyakini dengan mengimplementasikan Pedoman Gizi Seimbang secara benar, semua masalah gizi dapat diatasi (Kemenkes, 2014b).

Makanan dan gizi sangat penting untuk kesehatan balita. Kebiasaan makan berpengaruh pada siklus kehidupan yaitu pada penampilan, energi, stamina, daya tahan terhadap penyakit, keseimbangan mental, tingkat stress, pencapaian prestasi akademis dan kesuksesan kehidupan bermasyarakat (Hitchcock, Schubert, 2003). Gizi yang baik adalah bahan dasar untuk membantu anak-anak tumbuh kuat, bugar dan sehat. Kebiasaan makan yang keliru dapat mempengaruhi status gizi balita, oleh sebab itu perlu perhatian khusus dalam pemberian makan pada balita (Edelman, Kudzma, 2014).

Pemberian makanan yang sebaik-baiknya pada balita harus memperhatikan keseimbangan gizi. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan prinsip Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Orang tua harus membiasakan dan mengajarkan balita mengkonsumsi makanan sesuai prinsip Pedoman gizi seimbang (PGS). PGS adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis & jumlah yang sesuai dengan kebutuhan hidup, dengan memperhatikan 4 prinsip yaitu: 1) variasi makanan, 2) pentingnya pola hidup bersih, 3) pentingnya pola hidup aktif & olahraga serta 4) pemantauan berat badan ideal (Nakita, 2013). Berikut penjelasan masing-masing prinsip gizi seimbang.

Prinsip gizi seimbang yang pertama adalah variasi makanan. Variasi makanan merupakan prinsip pertama gizi seimbang yang universal. Balita membutuhkan makanan yang beraneka ragam atau bervariasi karena tidak ada

satupun makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara lengkap kecuali ASI. Pola makan seimbang bukan hanya memperhatikan sumber- sumber zat gizi makro (karbohidrat, lemak, dan protein) dan air, melainkan juga sumber-sumber zat gizi mikro meliputi vitamin dan mineral (Nakita, 2013).

Beranekaragam dalam prinsip ini selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Contohnya, saat ini dianjurkan mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Demikian pula jumlah makanan yang mengandung gula, garam dan lemak yang dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit tidak menular, dianjurkan untuk dikurangi. Akhir-akhir ini minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang oleh karena pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi (Kemenkes, 2014b).

Keragaman makanan anak setiap hari harus memenuhi kebutuhan akan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Pada prinsipnya, setiap makanan yang dihidangkan, dari makanan pagi, siang dan malam, serta makanan selingan harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, sehingga seluruh makanan akan memenuhi prinsip gizi seimbang. Oleh karena itu kebutuhan makan anak dalam sehari harus diperhatikan keluarga, karena pola makan bisa mempengaruhi status gizi balita (Nakita, 2013).

Prinsip gizi seimbang yang kedua adalah pola hidup

bersih. Dalam prinsip gizi seimbang, kesehatan tidak dilihat dari aspek makanan saja, tetapi juga dilihat dari pola hidup bersih. Pola hidup bersih perlu diajarkan pada anak usia balita. Kebiasaan pola hidup bersih meliputi mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan harus dilakukan sebelum dan setelah makan, setelah bermain, dan setelah buang air kecil atau buang air besar, lalu dikeringkan dengan tisu/lap bersih. Keluarga harus membiasakan menggunakan tutup saji, tidak memegang makanan langsung dengan tangan, tetapi dengan menggunakan sendok. Selain itu balita harus diajarkan menjaga kebersihan gigi dan mulut serta kebersihan badan (Nakita, 2013).

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama anak-anak. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Sebaliknya pada keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme pada orang yang menderita infeksi terutama apabila disertai panas. Pada orang yang menderita penyakit diare, berarti mengalami kehilangan zat gizi dan cairan secara langsung akan memperburuk kondisinya. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang menderita kurang gizi akan mempunyai risiko terkena penyakit infeksi karena pada keadaan kurang gizi daya tahan tubuh seseorang menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik (Kemenkes, 2014b).

Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi.

Contoh: 1) selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil, akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit antara lain kuman penyakit typhus dan disentri; 2) menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihindangi lalat dan binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit; 3) selalu menutup mulut dan hidung bila bersin, agar tidak menyebarkan kuman penyakit; dan 4) selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan (Kemenkes, 2014b).

Prinsip gizi seimbang yang ketiga adalah aktifitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik yang teratur akan meningkatkan kesempatan hidup sehat lebih panjang. Dasar sederhana adalah mempertahankan berat badan normal, seimbang kalori yang dimakan dan kalori yang digunakan (dibakar). Karena itu pola konsumsi makanan yang sehat disertai aktivitas fisik dalam lingkungan bebas polusi termasuk yang ada asap rokok akan membantu mengontrol berat badan, sehingga badan akan menjadi lebih sehat. (Kemenkes, 2014b).

Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Aktivitas fisik merupakan bagian penting untuk mengimbangi makanan yang dikonsumsi serta menjaga kesehatan dan kebugaran.

Keluarga perlu membantu balita melakukan aktifitas luar ruang atau olahraga setiap hari minimal 60 menit. Aktifitas yang dianjurkan untuk balita adalah aktifitas fisik yang banyak mengeluarkan tenaga (permainan aktif), bukan permainan pasif seperti *computer games* dan *play station*. Beberapa permainan fisik dapat dilakukan seperti permainan cilukba, dorong-dorongan, loncat bantal, kejar-kejaran, berenang, bola kaki, jalan/lari (Nakita, 2013).

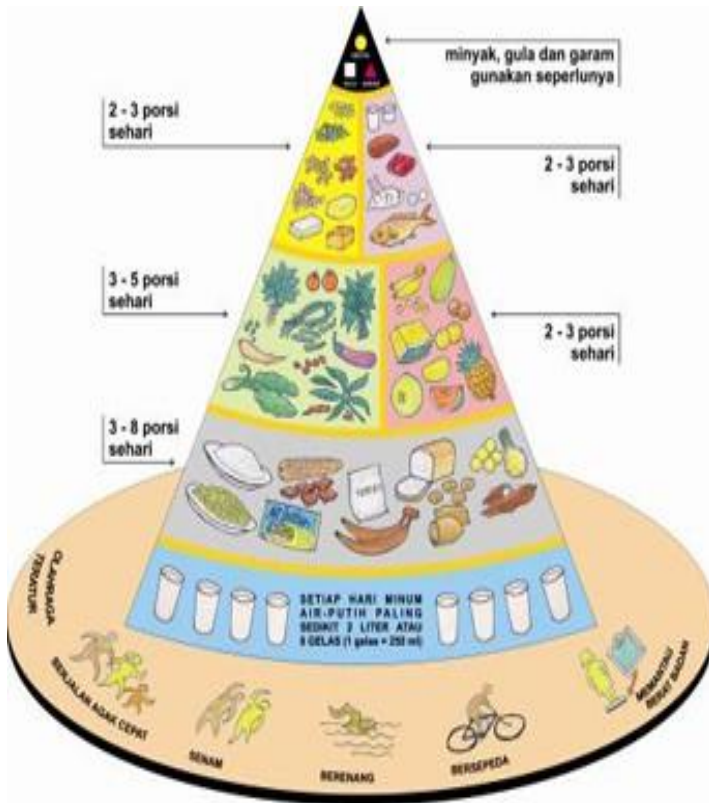
Prinsip gizi seimbang yang ke empat adalah pemantauan berat badan ideal. Bagi bayi dan balita indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan pertambahan umur. Pemantauannya dilakukan dengan menggunakan KMS. Oleh karena itu, pemantauan BB normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari 'Pola Hidup' dengan 'Gizi Seimbang', sehingga dapat mencegah penyimpangan BB dari BB normal, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya (Kemenkes, 2014b).

Berat badan bayi baru lahir minimal harus mencapai 2.500 g agar bayi tumbuh kembang sehat dan cerdas. Pemantauan berat bayi dan anak dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). Anak dinyatakan sehat jika berat badannya naik setiap bulan yaitu grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan kenaikan berat badan minimum atau lebih yang masih berada di dalam pita hijau KMS. (lihat Tabel Indeks Masa Tubuh (IMT) dan Kartu Menuju Sehat (Kemenkes, 2014b)

Kartu Menuju Sehat (KMS) bermanfaat untuk memantau dan mengetahui ada tidaknya penurunan atau kenaikan berat badan. Prinsipnya, pada anak yang sehat

dengan bertambahnya umur, maka bertambah berat badannya sesuai grafik pertumbuhan yang normal. Bila berat badan balita 2 bulan berturut-turut tidak terjadi penambahan berat badan, berarti pertumbuhan anak terganggu. Menurut standar WHO, berat badan ideal anak laki-laki usia 2 tahun adalah 12,2 kg dan anak perempuan 11,5 kg. Setelah usia 2 – 5 tahun, penambahan berat badannya 2 – 2,5 kg per tahun. Keluarga perlu membawa balita ke posyandu setiap bulan untuk menimbang anak, dan memperoleh pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi, kapsul vitamin A, dan penyuluhan gizi (Nakita, 2013).

Prinsip gizi seimbang divisualisasikan dalam bentuk “Tumpeng Gizi Seimbang” yang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan usia dan kesehatan. Berbeda dengan konsep 4 Sehat 5 Sempurna yang menyamaratakan kebutuhan gizi semua orang, pedoman gizi seimbang berprinsip bahwa tiap golongan usia, jenis kelamin, kesehatan & aktifitas fisik memerlukan PGS yang berbeda, sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok tersebut. Setiap negara memiliki visualisasi yang disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing, untuk memudahkan pemahaman terhadap TGS. Di Indonesia, prinsip PGS divisualisasi dalam bentuk tumpeng dengan nampannya yang disebut dengan “Tumpeng Gizi Seimbang” (Nakita, 2013). Dibawah ini gambar visualisasi TGS di Indonesia:



Gambar 3.1 Bentuk Visual Pedoman Gizi Seimbang Indonesia

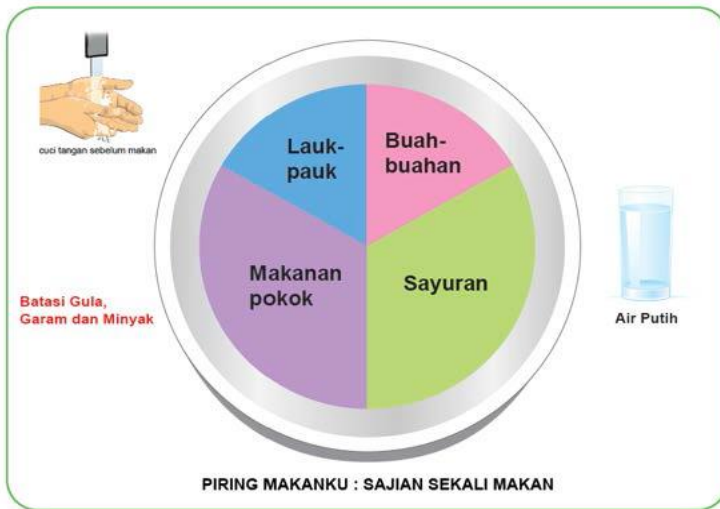
Tumpeng gizi seimbang (TGS) terdiri atas beberapa potongan tumpeng, yaitu : 1 potongan besar, 2 potongan sedang, 2 potongan kecil & di puncak terdapat potongan terkecil. Luasnya potongan TGS menunjukkan porsi konsumsi setiap orang per hari. Potongan TGS dialasi oleh air putih, artinya air putih merupakan bagian terbesar & zat gizi esensial bagi kehidupan, dalam sehari kebutuhan air putih yang harus dipenuhi balita adalah 5-7 gelas (Nakita, 2013).

Pada potongan tumpeng bagian atas terdapat

potongan besar yang merupakan golongan makanan pokok (sumber karbohidrat). Karbohidrat dianjurkan dikonsumsi 3-8 porsi/hari. Diatas bagian ini terdapat golongan sayuran (dianjurkan 3-5 porsi/hari) & buah (dianjurkan 2-3 porsi/hari) sebagai sumber serat, vitamin & mineral. Kemudian diatasnya lagi ada golongan makanan sumber protein, yang dibagi menjadi golongan protein nabati & hewani (dianjurkan dikonsumsi 2-3 porsi/hari). Pada puncak tumpeng terdapat golongan minyak, gula & garam yang dianjurkan untuk dikonsumsi seperlunya (Nakita, 2013)

Peranan berbagai kelompok bahan makanan secara jelas tergambar dalam logo gizi seimbang yang berbentuk kerucut (tumpeng). Dalam logo tersebut bahan makanan dikelompokkan berdasarkan fungsi utama zat gizi yang dalam ilmu gizi dipopulerkan dengan istilah "Tri Guna Makanan". *Pertama* sumber zat tenaga yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan. *Kedua*, sumber zat pengatur yaitu sayuran dan buah. *Ketiga*, sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani dan hasil olahan. Keseimbangan gizi diperoleh apabila hidangan sehari-hari terdiri dari sekaligus tiga kelompok bahan makanan. Dari setiap kelompok dipilih satu atau beberapa jenis bahan makanan (Nakita, 2013).

Selain makanan dan minuman dalam visual Tumpeng gizi seimbang (TGS) ini juga ada pesan cuci tangan sebelum dan sesudah makan yang divisualkan oleh gambar cuci tangan menggunakan air mengalir; juga berbagai siluet aktifitas fisik (termasuk olahraga), dan kegiatan menimbang berat badan. Kegiatan fisik dianjurkan untuk dilakukan paling tidak tiga kali seminggu dan memantau berat badan setiap bulan (Kemenkes, 2014b).



Gambar 3.2 Piring Makanku: Sajian Sekali Makan

Piring Makanku: Sajian Sekali Makan, dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan (misal sarapan, makan siang dan makan malam). Visual Piring Makanku ini menggambarkan anjuran makan sehat dimana separoh (50%) dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah, dan separoh (50%) lagi adalah makanan pokok dan lauk-pauk. Piring Makanku juga menganjurkan makan bahwa porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah, dan porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk-pauk. Piring makanku juga menganjurkan perlu minum setiap kali makan, bisa sebelum, ketika atau setelah makan. Meskipun gambar gelas hanya satu buah dalam visual ini, tidak berarti bahwa minum dalam satu kali makan hanya satu gelas, bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya segelas sebelum makan dan segelas lagi setelah makan. Makan dan minum tidak ada artinya bila tidak bersih dan

aman termasuk tangan dan peralatan makan. Oleh karena itu sejalan dengan prinsip gizi seimbang makan dalam visual Piring Makanku juga dianjurkan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena Piring Makanku adalah panduan setiap kali makan, maka tidak diperlukan anjuran aktivitas fisik dan pemantauan berat badan. Kedua hal ini cukup divisualkan pada gambar Tumpeng Gizi Seimbang (Kemenkes, 2014b).

Kebutuhan gizi pada anak usia 1-3 tahun 1125 kkal dan pada anak usia 4-6 tahun 1600 kkal yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Anjuran Jumlah Porsi Menurut Kecukupan Energi untuk Berbagai Kelompok Umur Untuk Kelompok Umur 1-3 tahun dan 4-6 tahun

Bahan Makanan	Anak Usia 1-3 tahun 1125 kkal	Anak Usia 4-6 tahun 1600 kkal
Nasi	3p	4p
Sayuran	1,5p	2p
Buah	3p	3p
Tempe	1p	2p
Daging	1p	2p
ASI		Dilanjutkan hingga 2 tahun
Susu	1p	1p
Minyak	3p	4p
Gula	2p	2p

Keterangan:

1. Nasi 1 porsi = $\frac{3}{4}$ gelas = 100 gr = 175 kkal
2. Sayuran 1 porsi = 1 gelas = 100 gr = 25 kkal
3. Buah 1 porsi = 1 buah pisang ambon = 50 gr = 50 kkal
4. Tempe 1 porsi = 2 potong sedang = 50 gr = 80 kkal
5. Daging 1 porsi = 1 potong sedang = 35 gr = 50 kkal

6. Ikan segar 1 porsi = 1/3 ekor = 45 gr = 50 kkal
7. Susu sapi cair 1 porsi = 1 gelas = 200 gr = 50 kkal
8. Susu rendah lemak 1 porsi = 4 sdm = 20 gr = 75 kkal
9. Minyak 1 porsi = 1 sdt = 5 gr = 50 kkal
10. Gula = 1 sdm = 20 gr = 50 kkal

*) sdm : sendok makan

**) sdt : sendok teh

p : porsi

Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi (Kemenkes, 2014b).

E. Gizi Seimbang Untuk Balita

Gizi Seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan cukup hanya dari ASI. ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan bayi sampai usia 6 bulan, sesuai dengan perkembangan sistem pencernaannya, murah dan bersih. Oleh karena itu setiap bayi harus memperoleh ASI Eksklusif yang berarti sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja (Kemenkes, 2014b).

Pada bayi dan anak usia 6-24 bulan, kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan tidak lagi dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Pada usia ini anak berada pada periode pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai terpapar terhadap infeksi dan secara fisik mulai aktif,

sehingga kebutuhan terhadap zat gizi harus terpenuhi dengan memperhitungkan aktivitas bayi/anak dan keadaan infeksi. Agar mencapai Gizi Seimbang maka perlu ditambah dengan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), sementara ASI tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Pada usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan kepada makanan lain, mula-mula dalam bentuk lumat, makanan lembik dan selanjutnya beralih ke makanan keluarga saat bayi mulai berusia 1 tahun (Kemenkes, 2014b).

Ibu sebaiknya memahami bahwa pola pemberian makanan secara seimbang pada usia dini akan berpengaruh terhadap selera makan anak selanjutnya. Sehingga pengenalan makanan yang beranekaragam pada periode ini menjadi sangat penting. Secara bertahap, variasi makanan untuk bayi usia 6-24 bulan semakin ditingkatkan, bayi mulai diberikan sayuran dan buah-buahan, lauk pauk sumber protein hewani dan nabati, serta makanan pokok sebagai sumber energi. Demikian pula jumlahnya ditambahkan secara bertahap dalam jumlah yang tidak berlebihan dan dalam proporsi yang juga seimbang (Kemenkes, 2014b).

Kebutuhan zat gizi anak pada usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya semakin meningkat. Demikian juga anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu atau pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar memilih makanan yang bergizi seimbang. Disamping itu anak pada usia ini sering keluar rumah sehingga mudah terkena penyakit infeksi dan kecacingan, sehingga perilaku hidup bersih perlu dibiasakan untuk mencegahnya (Kemenkes, 2014b).

F. Pesan Gizi seimbang

Pesan Gizi Seimbang untuk bayi usia 0-6 bulan yaitu melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan berikan ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan. Pemberian ASI Eksklusif berarti bayi selama 6 bulan hanya diberi ASI saja. Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya untuk bayi dapat dipenuhi dari ASI. Disamping itu pemberian ASI Eksklusif sampai dengan 6 bulan mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit (diare dan radang paru) dan mempercepat pemulihan bila sakit serta membantu menjalankan kelahiran. Pemberian ASI Eksklusif adalah hak bayi yang sangat terkait dengan komitmen ibu dan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar (Kemenkes, 2014b).

Pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun, oleh karena ASI masih mengandung zat-zat gizi yang penting walaupun jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan. Disamping itu akan meningkatkan hubungan emosional antara ibu dan bayi serta meningkatkan sistem kekebalan yang baik bagi bayi hingga ia dewasa. Selain ASI diteruskan harus memberikan makanan lain sebagai pendamping ASI yang diberikan pada bayi dan anak mulai usia 6-24 bulan. MP-ASI yang tepat dan baik merupakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi terutama *zat gizi mikro* sehingga bayi dan anak dapat tumbuh kembang dengan optimal. MP-ASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak, mulai dari MP-ASI bentuk lumat, lembik sampai anak menjadi terbiasa dengan makanan keluarga (Kemenkes, 2014b).

Pesan Gizi Seimbang untuk anak usia 2 – 5 Tahun (Kemenkes, 2014b):

- a. Biasakan makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam)

bersama keluarga

Dalam upaya memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari dianjurkan agar anak makan secara teratur 3 kali sehari dimulai dengan sarapan atau makan pagi, makan siang dan makan malam. Selain makan utama 3 kali sehari anak usia ini juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan selingan sehat. Untuk menghindarkan/mengurangi anak-anak mengonsumsi makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga. Sarapan setiap hari penting terutama bagi anak-anak karena mereka sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan secara teratur.

- b. Perbanyak mengonsumsi makanan kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, dan tahu

Pertumbuhan anak membutuhkan pangan sumber protein dan sumber lemak kaya Omega 3, DHA, EPA yang banyak terkandung dalam ikan. Anak-anak dianjurkan banyak mengonsumsi ikan dan telur karena kedua jenis pangan tersebut mempunyai kualitas protein yang baik. Tempe dan tahu merupakan sumber protein nabati yang kualitasnya baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Jika memberikan susu kepada anak, tidak perlu menambahkan gula pada saat menyiapkannya. Pemberian susu dengan kadar gula yang tinggi akan membuat selera anak terpaku pada kadar kemanisan yang tinggi. Pola makan yang terbiasa manis akan membahayakan kesehatannya di masa yang akan datang. Seperti disampaikan dalam pesan umum nomor 5 tentang batasi konsumsi pangan yang manis.

- c. Perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan.

Sayuran dan buah-buahan adalah pangan sumber vitamin, mineral dan serat. Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan, yang mempunyai fungsi antara lain untuk mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk memperlancar pencernaan dan dapat mencegah dan menghambat perkembangan sel kanker usus besar.

- d. Batasi mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin dan berlemak.

Pangan manis, asin dan berlemak dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis tidak menular seperti tekanan darah tinggi, hiperkolesterol, hiperglikemia, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Sesuai dalam pesan umum nomor 5 tentang batasi konsumsi pangan yang manis.

- e. Minumlah air putih sesuai kebutuhan.

Sangat dianjurkan agar anak-anak tidak membiasakan minum minuman manis atau bersoda, karena jenis minuman tersebut kandungan gulanya tinggi. Untuk mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari dianjurkan agar anak-anak minum air sebanyak 1200-1500 ml air/hari, sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.

- f. Biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari

Perkembangan teknologi mainan dan kemudahan akses anak pada permainan dengan teknologi canggih (*electronic game*) tanpa aktivitas fisik, dapat menimbulkan kegemukan dan gangguan perkembangan mental serta psikomotorik anak.

Permainan tradisional dan bermain bersama teman

penting untuk anak-anak karena dapat melatih dan menstimulasi kemampuan sosial dan mental anak. Selain itu, permainan tradisional dan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik dalam bentuk permainan dapat mengusir rasa bosan pada anak dan merangsang perkembangan kreativitasnya. Hal ini akan mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

BAB 4

TUGAS KESEHATAN KELUARGA DALAM MENINGKATKAN GIZI BALITA

A. Pengertian Keluarga

Definisi keluarga yang sering digunakan adalah bahwa keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah dan ikatan adopsi. Anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam suatu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran sosial keluarga seperti suami istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, keluarga juga menggunakan budaya yang sama, yaitu budaya yang dipelajari dari masyarakat dengan beberapa cara unik tersendiri (Burgess, dkk., dalam Friedman 2010). Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan-ikatan kebersamaan dan ikatan emosional dan yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

Keluarga merupakan kumpulan dua individu atau lebih yang saling ketergantungan dan memiliki keterikatan satu sama lain dalam hal emosional, fisik, dan dukungan ekonomi. Keluarga sehat adalah sebuah dinamisasi, perubahan status kesejahteraan yang di dalamnya termasuk biologis, psikologis, spiritual, sosial dan faktor budaya dari setiap anggota keluarga dan sistem keluarga secara luas (Kaakinen

& Melissa, 2018). Interaksi antar anggota keluarga akan saling mempengaruhi dan berdampak pada sistem keluarga tersebut (Maglaya, 2009).

B. Peran dan Fungsi Keluarga

Status sehat/sakit para anggota keluarga dalam keluarga saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, keluarga cenderung menjadi seorang reaktor terhadap masalah-masalah kesehatan dan menjadi aktor dalam menentukan masalah-masalah kesehatan anggota keluarga. Keluarga cenderung terlibat dalam pembuatan keputusan dan proses terapeutik pada setiap tahap sehat dan sakit pada setiap anggota keluarga, seperti mulai dari keadaan sehat hingga diagnosa, tindakan hingga penyembuhan. Secara umum diakui bahwa keberadaan keluarga adalah untuk memenuhi fungsi-fungsi dasar tertentu. Fungsi-fungsi keluarga dicapai melalui pencapaian peran-peran keluarga (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

Peran adalah pola tingkah laku yang ditentukan atau diharapkan dari orang-orang yang mempunyai fungsi tertentu. Peran keluarga dalam memenuhi gizi balita dipengaruhi oleh budaya. Budaya yang berlaku dalam keluarga dapat berbentuk norma dan nilai-nilai keluarga. Pengetahuan tentang inti dari nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan makan, dan tradisi makan sangat penting untuk menginterpretasikan apakah peran keluarga telah sesuai atau belum (Holman, 1983 dalam (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010). Pola budaya makan dalam keluarga mempengaruhi pemilihan makanan dan pola makan yang akan diberikan pada balita. Praktek agama dapat mempengaruhi pemilihan makanan dan pola makan. Seperti contohnya di India orang tidak boleh makan sapi, tapi

mengganti protein dan pola makan dalam keluarga merupakan bentuk peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi. Berfungsinya peran secara adekuat merupakan hal yang penting untuk keberhasilan fungsi keluarga.

Fungsi keluarga akan efektif bila keluarga dapat mencapai dan memelihara kondisi fisik, emosi, interpersonal, dan kesehatan kerja. Keluarga yang sehat akan dapat berfungsi dengan baik, bila menghadapi kesulitan. Status gizi pada balita dapat dikaitkan dengan fungsi keluarga. 5 fungsi keluarga diantaranya fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010). Berikut penjelasan masing-masing fungsi keluarga dan kaitannya dengan status gizi balita.

Fungsi afektif berhubungan dengan fungsi-fungsi internal keluarga, perlindungan dan dukungan psikososial bagi para anggotanya. Fungsi afektif meliputi persepsi keluarga tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikososial anggota keluarga. (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010). Pada balita, makan adalah masa belajar, cinta dan interaksi yang mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial dan emosional. Keluarga harus berbicara dengan anak-anak, dan memperlakukan anak selama makan dengan sabar. Makan memberikan kesempatan untuk orang tua atau anggota keluarga lainnya untuk berinteraksi dan berbicara dengan anak-anak dan mendukung pembelajaran mereka, sehingga merangsang perkembangan psikososial. Oleh`sebab itu keluarga perlu mendorong dan membantu pembelajaran makan pada balita (UNICEF., 2023).

Fungsi sosialisasi lebih sering merujuk pada

bagaimana pengalaman keluarga dalam mengajarkan anak berfungsi dan menerima peran-peran dewasa di masyarakat. Salah satu aspek dari proses sosialisasi termasuk upaya anak memperoleh konsep tentang kesehatan, sikap, perilaku, kontrol dan nilai-nilai, belajar disiplin, dan sanksi (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010). Penting mengajarkan balita makan dengan peralatan (piring, sendok/garpu), mensosialisasikan balita dengan aneka ragam makanan dan kebiasaan makan yang sehat karena melalui pembelajaran ini, balita akan belajar gaya hidup yang sehat (Allender, Rector, 2010).

Hasil studi tentang perubahan positif tentang kedua orang tua yang bekerja, bila peran keluarga lebih fleksibel dan ada kerjasama antara anggota keluarga untuk memenuhi tugas keluarga secara utuh. Pada beberapa keluarga, ibu yang bekerja diluar rumah harus banyak meluangkan waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah ketika pulang kerja termasuk dalam menyiapkan makanan untuk anggota keluarga (Hitchcock, Schubert, 2003).

Fungsi reproduksi, dimasa lampau merupakan fungsi dasar keluarga dalam kehidupan di masyarakat. Pada keluarga sekarang, mempunyai kecenderungan untuk mengurangi atau mengendalikan kelahiran anggota keluarga baru. Jumlah anak yang besar dalam satu keluarga akan dapat mempengaruhi status gizi balita karena berhubungan dengan kurangnya ketersediaan pangan (Allender, J.A & Spradley, 2005).

Fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi perawatan kesehatan merupakan fungsi yang mendasar dan vital, dan menjadi fokus sentral dalam keluarga yang sehat dan berfungsi dengan baik. Fungsi perawatan kesehatan melibatkan penyediaan kebutuhan fisik untuk menjaga keluarga sehat, seperti makanan, pakaian, perlindungan bahaya, perawatan kesehatan dan praktek-praktek kesehatan yang mempengaruhi status kesehatan keluarga (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

Keluarga berperan mengajarkan dan membantu balita makan makanan bervariasi dengan gizi seimbang, mengatur jadwal makan balita, membatasi asupan gula, memotivasi balita dengan aktifitas-aktifitas yang melibatkan banyak gerakan, membantu hygiene gigi, dan mengontrol berat badan balita agar seimbang. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

**Gambar 3.3 Figure lima peran dan fungsi dasar keluarga
(Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010)**

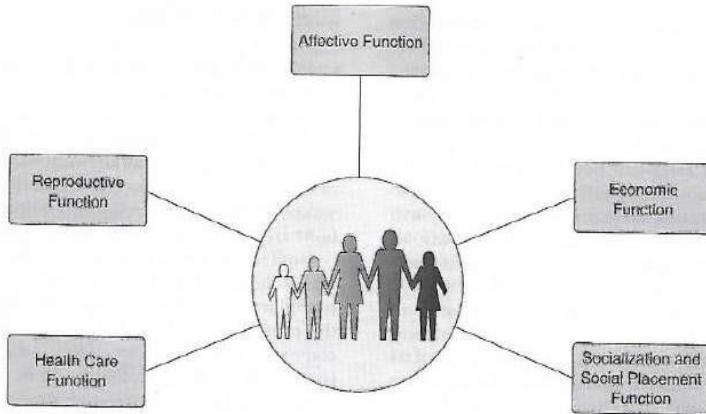


Figure 4-1. The five basic family functions.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi Sosial Budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, Diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi perlindungan dan pola asuh, bertujuan untuk

mengasuh, membesarkan dan melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

5. Fungsi reproduksi, Merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga
6. Fungsi sosialisasi, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik dan mensekolahkan anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, fungsi ini dilakukan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, aman penuh keindahan. kembangkan menjadi tugas keluarga dibidang kesehatan.

C. Tugas Kesehatan Keluarga

Tugas kesehatan keluarga merupakan cerminan dari kemampuan keluarga dalam mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan keluarga. Keluarga memiliki fungsi dalam menjalankan perawatan kesehatan. Salah satu indikator keberhasilan Program Indonesia Sehat adalah

terciptanya keluarga sehat, sehingga dalam pelaksanaan program, perlu adanya fokus pendekatan pada keluarga. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) tertuang dalam Permenkes No. 39 Tahun 2016 merupakan program yang mengintegrasikan beberapa aspek dengan 12 indikator keluarga sehat. Keluarga sehat merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian keluarga baik (Kemenkes RI, 2020).

Tugas kesehatan keluarga adalah 1) kemampuan mengenal masalah: definisi, penyebab dan tanda-tanda masalah, 2) kemampuan mengambil keputusan: menurut keluarga apa akibat masalah, dan apakah menurut keluarga sangat penting melakukan penanggulangan masalah, 3) kemampuan memberikan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan: apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah, apakah keluarga mengetahui alternatif perawatan, hambatan apa dalam penanggulangan masalah di rumah, 4) kemampuan memodifikasi lingkungan: bagaimana keluarga mengatur lingkungan (fisik, psikologis, sosial) yang dapat menunjang keberhasilan penanggulangan masalah, apa yang keluarga ketahui alasan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, 5) kemampuan memanfaatkan kesehatan: apa saja yang diperoleh di Polindes/Pustu/Puskesmas/Rumah Sakit, adakah hambatan yang dihadapi untuk memanfaatkan sarana/fasilitas kesehatan (Kemenkes, 2006; Maglaya, 2009).

Tugas kesehatan keluarga terkait gizi meliputi, 1) mengenal masalah: apa yang keluarga ketahui tentang gizi, triguna makanan dan manfaatnya, penyebab dan tanda-tanda masalah gizi, 2) mengambil keputusan: menurut keluarga apa akibat masalah gizi bila tidak seimbang, apakah menurut keluarga sangat penting melakukan

penanggulangan masalah gizi, 3) kemampuan memberikan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan: apa yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah gizi, bagaimana cara memilih, mengolah dan menyimpan makanan, apakah keluarga mengetahui alternatif perawatan anggota dengan masalah gizi, hambatan apa dalam penanggulangan masalah gizi di rumah, 4) kemampuan memodifikasi lingkungan: bagaimana keluarga mengatur lingkungan (fisik, psikologis, sosial) yang dapat menunjang keberhasilan penanggulangan masalah gizi, apa yang keluarga ketahui alasan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, 5) kemampuan memanfaatkan fasilitas kesehatan: apa saja yang diperoleh di Polindes/Pustu/Puskesmas/Rumah Sakit, adakah hambatan yang dihadapi untuk memanfaatkan sarana/fasilitas kesehatan (Hidayati, 2011).

(Kemenkes, 2006) mengemukakan kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga sangat diperlukan, agar keluarga dapat meningkatkan status gizi anak balita dirumah. Kemandirian keluarga yang berorientasi pada 5 tugas kesehatan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya. Keluarga yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya dapat dinilai dengan tingkat kemandirian keluarga. Kemandirian keluarga dalam program perawatan kesehatan masyarakat dibagi dalam empat tingkatan yaitu keluarga mandiri tingkat I (paling rendah) sampai keluarga mandiri tingkat IV (paling tinggi). Kriteria keluarga mandiri adalah sebagai berikut:

Keluarga mandiri tingkat pertama (KM - I) Kriteria: a). Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat. b). Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan.

Keluarga mandiri tingkat dua (KM - II) Kriteria: a). Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat. b). Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan. c). Tahu dan mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar. d). Melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan.

Keluarga mandiri Tingkat Tiga (KM – III) kriteria: a). Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat. b). Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan. c). Tahu dan mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar. d). Melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan. e). Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif. f). Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif.

Keluarga mandiri Tingkat Empat (KM – IV) kriteria: a). Menerima petugas perawatan kesehatan masyarakat. b). Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan. c). Tahu dan mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar. d). Melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan. e). Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif. f). Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif. g). Melaksanakan tindakan promotif secara aktif (Kemenkes, 2006, 2010). Kriteria keluarga mandiri adalah sebagai berikut: Tingkat kemandirian keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Kemandirian Keluarga

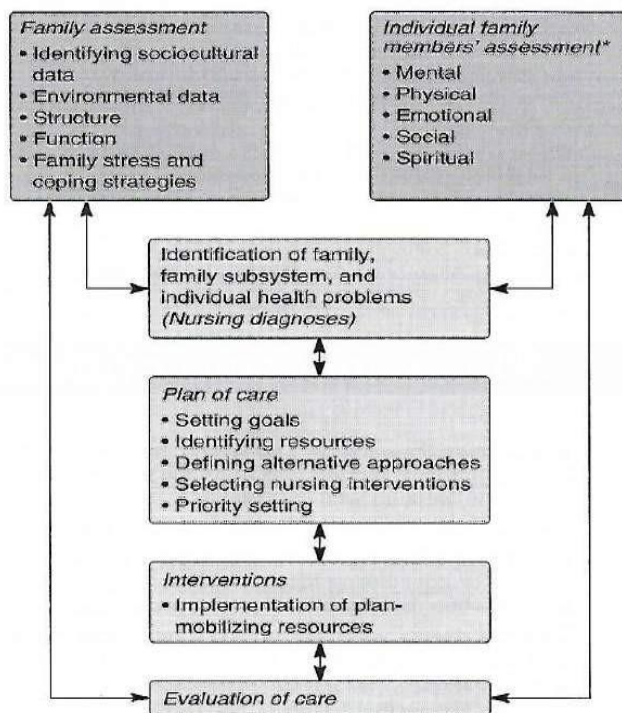
No	Kriteria	Tingkat Kemandirian keluarga			
		I	II	III	IV
1.	Menerima petugas	√	√	√	√
2.	Menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana keperawatan	√	√	√	√
3.	Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar		√	√	√
4.	Memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran		√	√	√
5.	Melakukan tindakan keperawatan sederhana sesuai anjuran		√	√	√
6.	Melakukan tindakan pencegahan secara aktif			√	√
7.	Melakukan tindakan peningkatan (promotif) secara aktif				√

D. Konsep Model Family Centered Nursing

Dalam keperawatan keluarga penerapan proses keperawatan merupakan proses yang komprehensif sehingga memerlukan pendekatan logis dan sistematis dalam bekerja dengan keluarga dan individu. Model ini menekankan keluarga sebagai sistem terbuka yang saling berinteraksi satu sama lain, oleh karena itu keperawatan keluarga yang diberikan difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga

melalui perbaikan dinamika hubungan internal keluarga, struktur, fungsi dan interdependensi antar anggota keluarga. Model ini mengintegrasikan teori sistem, dimana anggota keluarga dipandang sebagai subsistem yang saling berinteraksi, sedang kelompok masyarakat dianggap mewakili supra sistem. Model ini memberikan suatu kerangka kerja untuk mengkaji keluarga dengan premis proses keperawatan keluarga diantaranya pengkajian terhadap keluarga, Pengkajian anggota keluarga (indifidu), menentukan diagnosis keperawatan, Rencana keperawatan, intervensi dan evaluasi dari intervensi yang dilakukan (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010).

Family Centered Nursing menekankan penerapan asuhan keperawatan keluarga yang difokuskan pada peningkatan serta keluarga untuk perawatan indifidu, prosesnya meliputi Pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi. Model langkah-langkah proses keperawatan keluarga menurut friedman:



Gambar 3.4 Model *Family Centered Nursing* (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010)

Model pengkajian teori *Family Centered Nursing menurut* (Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, 2010) terdiri dari 6 komponen yaitu:

1. Sosial budaya

Sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk dan/atau dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannyayang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak berarti pula penciptaan sosial budaya itu kemudian tak memiliki

dampak negatif. Bila kebudayaan yang ada kemudian menimbulkan akses negatif bagi kehidupan sosial adalah sesuatu yang perlu dipikirkan ulang, jika ingin menciptakan sebuah budaya. Beberapa dampak negatif kebudayaan bagi kehidupan sosial manusia, antara lain: menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuknya tingginya tingkat kriminalitas, mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat. Selain dari itu nilai merupakan salah satu dari sebuah keyakinan abadi yang mempunyai bentuk perilaku. Sedangkan nilai – nilai keluarga didefinisikan sebagai suatu sistem ide, sikap, dan kepercayaan tentang nilai suatu keseluruhan atau konsep yang secara sadar maupun tidak sadar mengikat bersama – sama seluruh anggota keluarga dalam suatu budaya lazim.

2. Tahap dan riwayat perkembangan keluarga

Perkembangan keluarga merupakan proses perubahan yg terjadi pada sistem keluarga meliputi; perubahan pola interaksi & hubungan antar anggota keluarga disepanjang waktu. Perubahan ini berlangsung melalui beberapa tahapan atau kurun waktu tertentu. Pada setiap tahapan memiliki tugas perkembangan yg mesti dipenuhi supaya tahapan tersebut bisa dilalui dengan berhasil.

3. Lingkungan.

Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang

tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

4. Struktur keluarga

pola dari kedudukan dan tugas yang ada didalamnya dari anggota keluarga tersebut.

5. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga diantaranya fungsi afektif, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Stres, koping dan adaptasi keluarga

6. Stres, koping dan adaptasi keluarga

Koping merupakan cara yang dapat dilakukan individu/keluarga, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, menyesuaikan diri dengan keinginan yang akan dicapai, dan respons terhadap situasi yang menjadi ancaman bagi diri individu

E. Pengaruh Tugas Kesehatan Keluarga Terhadap Status Gizi Balita Dengan Pendekatan Model Family Centered Nursing

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi balita (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2024). Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 mengemukakan bahwa angka stunting di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 21,6% dimana pada tahun 2021 sebanyak 24,4. Pada tahun 2022 angka stunting di Indonesia mengalami penurunan 2,8%, sedangkan target penurunan angka stunting di Indonesia 14% pada tahun 2024, sehingga perlu penurunan

3,8% untuk mencapai target yang di inginkan. Sedangkan balita dengan status gizi kurang dengan badan pendek meningkat sebanyak 7,7% dimana pada tahun 2022 peningkatan pada balita dengan gizi kurang sebanyak 0,6% dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 7,1% (SSGI, 2023). Pencapaian tersebut belum mampu mencapai target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk pembangunan berkelanjutan kedua yang mengakhiri segalanya bentuk malnutrisi pada tahun 2030 (Susanto, T., Yunanto, R. A., Rasny, H. & L. S., dan Nur, 2019). Upaya promotif dan preventif harus tetap dilakukan dan ditingkatkan untuk percepatan dan penurunan malnutrisi pada balita.

Hasil penelitian tentang pengaruh tugas kesehatan keluarga terhadap status gizi balita dengan pendekatan model Familiy Centered Nursing (FCN) menunjukkan pada kelompok intervensi setelah dilaksanakan tugas kesehatan keluarga terjadi peningkatan status gizi dengan berat badan normal sebanyak 5,3%. Kelompok intervensi berdasarkan uji Wilcoxon Signed Ranks Test diperoleh terjadi perubahan positif yaitu peningkatan status gizi pada 5 responden. Hasil P-value $0,025 < 0,05$ artinya ada pengaruh tugas kesehatan keluarga terhadap status gizi balita dengan menggunakan model FCN pada kelompok intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol P-value $0,025 < 0,157$ artinya tidak ada pengaruh tugas kesehatan keluarga terhadap status gizi balita dengan menggunakan model FCN pada kelompok kontrol (Hidayati RN, Ibnu F, 2025).

Keluarga merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi status gizi balita. Keluarga harus berpartisipasi aktif dalam memantau status gizi balita. Oleh karena itu, Penyelenggaraan fungsi keluarga dalam

lingkungan keluarga besar harus dioptimalkan untuk meningkatkan gizi status balita (Febrianti et al., 2022). *Family Centered Nursing Model* menekankan pentingnya keluarga dalam mengenali masalah kesehatan dan terlibat dalam strategi manajemen kesehatan yang efektif. Pemberdayaan keluarga melalui *Family Centered Nursing Model* memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanganan masalah stunting (Fajar et al., 2023). Optimalisasi tugas kesehatan keluarga dengan pendekatan *Family Centered Nursing Model* meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Hidayati, 2011) diperoleh bahwa tugas kesehatan keluarga yang baik (keluarga mandiri III & IV) 81,9% memiliki balita dengan status gizi baik, dibandingkan dengan keluarga yang dengan tugas kesehatan keluarga kurang (keluarga mandiri I & II) 72,7 % memiliki balita dengan status gizi baik.

Hasil penelitian (Hastuti et al., 2024) menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan ibu dalam memenuhi gizi setelah diberikan intervensi pemberdayaan keluarga pada keluarga dengan anak stunting usia 6-24 bulan yaitu penyiapan dan pengolahan makanan ($p=0.000$), pemberian makanan pendamping ASI ($p=0.000$), dan pemberian makanan responsif ($p=0.000$). Penelitian (Heryyanoor et al., 2022) mengungkapkan melalui pembinaan keluarga dengan model *Family Centered Nursing* berhasil meningkatkan pengetahuan dan sikap keluarga tentang pencegahan malnutrisi balita. Penelitian (Januarti et al., 2020) menyebutkan pemberdayaan keluarga berdasarkan model *Family Centered Care* dapat meningkatkan pencegahan balita stunting.

Keluarga memiliki peranan yang penting bagi peningkatan dan pengawasan status gizi balita. Studi tentang Gerakan PELITA "Peduli Gizi Balita" yang diberikan melalui edukasi gizi dan pembinaan pada keluarga melalui kunjungan rumah efektif meningkatkan kemampuan keluarga meningkat menjadi 63,6% baik. Ada pengaruh Gerakan PELITA "Peduli Gizi Balita" dalam meningkatkan kemampuan keluarga mengatasi gizi kurang balita ($P\text{-value } 0,001 < 0,05$) (Hidayati RN, 2025).

Penelitian (Anna et al., 2019) di Vietnam mengemukakan mendukung kebiasaan makan sehat dalam keluarga dan mengelola sumber daya terbatas digunakan sebagai alat dalam menurunkan malnutrisi di Vietnam. Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan dengan balita stunting sangat diperlukan agar balita mendapatkan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi antara tenaga kesehatan dan keluarga (Nuraeni & Rosiah, 2023). Hal ini sesuai dengan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga (Hartati et al., 2021).

Optimalisasi tugas kesehatan keluarga dapat menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang berfokus pada peningkatan status gizi balita dengan mendukung pembiasaan makan sehat, mengoptimalkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya terbatas keluarga dengan melalui pembimbingan dan pendampingan petugas kesehatan.

BAB 5

PENUTUP

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah status gizi balita. Gizi berkontribusi lebih dari sepertiga dari semua kematian pada balita di dunia. Kekurangan gizi yang dialami balita akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita hingga dewasa dan bersifat irreversible.

Keluarga memiliki peranan yang penting bagi peningkatan dan pengawasan status gizi balita. Pemahaman keluarga tentang pelaksanaan tugas kesehatan keluarga sangat diperlukan agar keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi balita secara tepat dan mencegah masalah gizi balita. Kemandirian keluarga berorientasi pada tugas kesehatan keluarga dalam mengatasi masalah gizi meliputi: 1) mengenal masalah gizi, 2) mengambil keputusan dalam melakukan penanggulangan masalah gizi, 3) kemampuan memberikan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan malnutrisi, 4) kemampuan memodifikasi lingkungan: bagaimana keluarga mengatur lingkungan (fisik, psikologis, sosial) yang dapat menunjang keberhasilan penanggulangan masalah gizi, 5) kemampuan memanfaatkan fasilitas kesehatan.

Tugas kesehatan keluarga efektif meningkatkan status gizi balita dengan menggunakan model *Family Centered Nursing* (FCN). Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga yang optimal berpengaruh pada peningkatan status gizi (berat badan normal) balita. Optimalisasi tugas kesehatan keluarga dapat menjadi solusi strategis dalam program kesehatan masyarakat yang

berfokus pada peningkatan status gizi balita dengan mendukung pembiasaan makan sehat, mengoptimalkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya terbatas keluarga dengan melalui pembimbingan dan pendampingan petugas kesehatan.

Tenaga kesehatan terutama Perawat Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) diharapkan melakukan pendampingan dan pembimbingan pada keluarga agar keluarga mandiri dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga sehingga status gizi balita bisa meningkat. Perawat perlu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Sumber-sumber pendukung dalam keluarga merupakan faktor yang meningkatkan kemandirian dalam keluarga, sehingga perawat perlu memaksimalkan potensi positif dalam keluarga.

Penelitian lebih lanjut kearah *action research* terkait dengan model intervensi yang dapat dipraktikkan pada keluarga dengan masalah gizi balita perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan model ini dapat digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga sehingga diharapkan berdampak pada pemecahan masalah kelompok balita dengan risiko tinggi masalah gizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, D. (2013). *Tumbuh Kembang & Terapi Bermain Pada Anak*. Selemba Medika.
- Allender, J.A & Spradley, B. W. (2005). *Community health nursing: promoting and protecting the public health*. (5 th ed). Lippincott.
- Allender, Rector, W. (2010). *Community health nursing: promoting and protecting the public health* (7th Editio). Lippincott Williams & Wilkins.
- Anna, H., Hedvig, F., & Kristina, R. (2019). Family-Centered Care - A Tool to Decrease Malnutrition among Children in Vietnam. *International Archives of Nursing and Health Care*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.23937/2469-5823/1510116>
- Apriluana, G., & Fikawati, S. (2018). Analisis faktor-faktor risiko terhadap kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di negara berkembang dan asia tenggara. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 247–256.
- Ariani, A. (2017). *Ilmu gizi: dilengkapi dengan standar penilaian status gizi dan daftar komposisi bahan makanan* (Cetakan 1). Nuha Medika.
- Arisman. (2014). *Gizi dalam daur kehidupan*. (2nd ed.). EGC.
- Dinkes Provinsi Jawa Timur. (2024). *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023*.
- Edelman, Kudzma, M. (2014). *Health promotion throughout the life span* (eighth edi). St. Louis, Missouri: Elsevier, 2014.

- Fajar, N. A., Zulkarnain, M., Taqwa, R., Sulaningsi, K., Ananingsih, E. S., Rachmayanti, R. D., & Sin, S. C. (2023). Family Roles and Support in Preventing Stunting: A Systematic Review. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), 50–57. <https://doi.org/10.14710/jpki.19.1.50-57>
- Febrianti, A. N., Susanto, T., & Rasni, H. (2022). Family Function and Nutritional Status among under-Five Children: A Cross-Sectional Study among Extended Family in Panti Public Health Center, Jember Regency of Indonesia. *International Journal of Caring Sciences*, 15(1), 1–417. www.internationaljournalofcaringsciences.org
- Friedman, M.M., Bowden, V.R. & Jones, E. G. (2010). *Family nursing: research, theory and practice*. (5 th ed). Prentice Hall.
- Hartati, N. S., Sulistiowati, E., & Susilawati, M. D. (2021). Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 31(3), 161–170. <https://doi.org/10.22435/mpk.v31i3.3381>
- Hastuti, A. P., Suprawoto, D. N., Roesardhyati, R., Kurniawan, A. W., Soares, D., & Fani, R. (2024). Family Empowerment to Fullfillment Nutrition in Stunted Children. *Babali Nursing Research*, 5(1), 54–66. <https://doi.org/10.37363/bnr.2024.51337>
- Heryyanoor, H., Hardiyanti, D., & Pertiwi, M. R. (2022). Improving Family Knowledge And Attitudes On Malnutrition Through Family Centered Nursing-

- Based Modules And Videos. *DINAMISA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 190–200.
- Hidayati, R. N. (2011). *Hubungan tugas kesehatan keluarga, karakteristik keluarga dan anak dengan status gizi balita di Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok*. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20282242>
- Hidayati RN, Ibnu F, S. (2025). The Effect Of Family Health Tasks On The Nutritional Status Of Children Under Five Years Old With The Family Centered Nursing (FCN) Model Approach. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta Yogyakarta*, 14(1).
- Hidayati RN, I. F. (2025). Gerakan PELITA di Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Wilayah UPT Puskesmas Gayaman Kab. Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 3(1).
- Hitchcock, Schubert, T. (2003). *Community Health Nursing: Caring in Action*. Thomson/Delmar Learning, 2003.
- Hockenberry M, Wilson D, W. D. (2016). *Wong's essentials of pediatric nursing*. (10 th edit). Mosby Inc. St. Louis.
- Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga.
- Januarti, L. F., Abdillah, A., & Priyanto, A. (2020). Family Empowerment Model in Stunting Prevention Based on Family Centered Nursing. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 1797–1806. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.536>

- Kaakinen, J. R., & Melissa, R. (2018). Family Health Care Nursing Sixth Edition. In *F.A. Davis Company*.
- Kemenkes. (2006). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Penyelegaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas*.
- Kemenkes. (2010). *Keputusan menteri kesehatan nomor 908/Menkes/SK VII/2010 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keluarga*.
<https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/69803a06-bdb3-457a-a727-413b5138913c/>
- Kemenkes. (2014a). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak*.
<https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/ffb9b802-9f1b-4d14-a945-2fa830ac0db0/unduh/>
- Kemenkes. (2014b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang*. Kemenkes.
- Kemenkes. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak*. Kemenkes RI.
https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_an_1660187306_961415.pdf
- Kemenkes. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. In Sekretariat Jenderal (Ed.), *Science as Culture*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2020). *Buku Saku Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk Pada Balita di Layanan Rawat*

- Jalan Bagi Tenaga Kesehatan. In *Kemenkes RI: Jakarta*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riskendas 2018. *Laporan Nasional Riskesdas 2018*, 44(8), 181–222. [http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK No. 57 Tahun 2013 tentang PTRM.pdf](http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK%20No.%2057%20Tahun%202013%20tentang%20PTRM.pdf)
- Maglaya. (2009). *Nursing practice in the community* (Fifth edit). Argonauta.
- Nakita. (2013). *Sehat & Bugar Berkat Gizi Seimbang*. Danone Institute.
- Nassar, et al. (2015). *Penuntun Diet Anak* (Edisi 3). Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Nuraeni, A., & Rosiah, R. (2023). Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan dan pencegahan stunting pada balita di Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Dan Teknologi Rekayasa*, 5(1), 46–51. <https://doi.org/10.31962/jiitr.v5i1.149>
- Potts, N. L., & Mandleco, B. L. (2012). *Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families* (3rd ed.). Clifton Park, NJ: Delmar.
- Putri, A. P., & Rong, J. R. (2021). Parenting functioning in stunting management: A concept analysis. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 213–219. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2160>
- Septiari, B. (2012). *Mencetak balita cerdas dan pola asuh orang tua* (Edisi 1). Nuha Medika.
- Sir, S. G., Aritonang, E. Y., & Jumirah, J. (2021). Praktik Pemberian Makanan dan Praktik Kesehatan

- dengan Kejadian Balita dengan Gizi Kurang. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 3(1), 37–42.
<https://doi.org/10.31539/joting.v3i1.2091>
- Soekirman. (2012). *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan.
- Soetjiningsih. (2016). *Tumbuh Kembang Anak*. EGC.
- SSGI. (2023). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
<https://promkes.kemkes.go.id/materi-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022>
- Stanhope, L. (2016). *Public Health Nursing: Population Centered Health Care In The Community*.
- Stanhope, & Lancaster. (2014). *Foundations of Nursing in the Community: Community-Oriented Practice*.
- Suhardin, S., Suwetty, A. M., Emry, M., Ledes, H., Riantiarno, F., Mella, O., & Banamtuan, D. A. (2024). *Family Experiences in Caring for Children with Stunting in Timor , East Nusa Tenggara , Indonesia: A Family-Centered Nursing Approach*. 4(1), 49–58.
<https://doi.org/10.47679/jchs.202486>
- Supariasa IDN, Bakri N, F. I. (2020). *Penilaian Status Gizi* (Edisi 2). EGC.
- Susanto, T., Yunanto, R. A., Rasny, H., S., & L. S., dan Nur, K. R. M. (2019). Promoting Children Growth And Development: A Community-Based Cluster Randomized Controlled Trial In Rural Areas Of Indonesia. *Jurnal Public Health Nursing*, March,

514–524.

UNICEF. (2023). *The state world's children*.
<https://www.unicef.org/indonesia/reports/state-worlds-children-2023>

UNICEF, WHO, & World Bank. (2023). Level and trend in child malnutrition. *World Health Organization*.

Vaughn, A. E., Ward, D. S., Fisher, J. O., Faith, M. S., Hughes, S. O., Kremers, S. P. J., Musher-Eizenman, D. R., O'Connor, T. M., Patrick, H., & Power, T. G. (2016). Fundamental constructs in food parenting practices: A content map to guide future research. *Nutrition Reviews*, 74(2), 98–117.
<https://doi.org/10.1093/nutrit/nuv061>

GLOSARIUM

A

Absorpsi: penyerapan

Adopsi: pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri

Afektif: berkenaan dengan perasaan, mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi

B

Budaya: sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah;

D

Diet: aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya

E

Eksternal: menyangkut bagian luar (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya)

Energi: daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, tenaga

G

Gizi: zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan

Genetik: keadaan unggul suatu sifat keturunan yang tampak di dalam penampilan

Gaya hidup: pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat;

H

Hiperkolesterolemia: keadaan terlalu tingginya kandungan kolesterol di dalam darah

Hipertensi: tekanan darah atau denyut jantung yang lebih tinggi daripada normal karena penyempitan pembuluh darah atau gangguan lainnya;

I

Internal: menyangkut bagian dalam (tubuh, diri, mobil, dan sebagainya)

Imunitas: keimunan; kekebalan;

K

Komplikasi: penyakit yang baru timbul kemudian sebagai tambahan pada penyakit yang sudah ada

Karbohidrat: senyawa organik karbon, hidrogen, dan oksigen, terdiri atas satu molekul gula sederhana atau lebih yang merupakan bahan makanan penting dan sumber tenaga (banyak terdapat dalam tumbuhan dan hewan)

Kecerdasan: perihal cerdas

Klinis: bersangkutan atau berdasarkan pengamatan klinik

Konsumtif: bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri)

Keterampilan social: kemampuan berinteraksi dengan orang lain

Kualitas: derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya)

Kuantitas: banyaknya (benda dan sebagainya); jumlah (sesuatu)

Krisis: keadaan yang berbahaya (dalam menderita sakit);

L

Lemak: zat minyak yang melekat pada daging

M

Massa tubuh: besar tubuh

Malnutrisi: kekurangan gizi

Mineral: zat organik yang dalam jumlah tertentu diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme normal yang diperoleh melalui makanan sehari-hari;

Metabolisme: pertukaran zat pada organisme yang meliputi proses fisika dan kimia, pembentukan dan penguraian zat di dalam badan yang memungkinkan berlangsungnya hidup

N

Nutrisi : proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh; makanan bergizi;

Nilai kesehatan: variable yang membantu untuk mengukur status

kesehatan

P

Pelayanan Kesehatan: sarana yang menyediakan bentuk pelayanan yang sifatnya lebih luas daripada bidang klinik, bersifat preventif, promotif, dan rehabilitatif

Protein hewani: protein yang dihasilkan dari hewan

Protein nabati: protein yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan

Pendapatan: perhitungan banyaknya uang yang akan diterima

Perawatan: proses, cara, merawat, pemeliharaan

Peran: perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat;

Prevalensi: jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi; pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah

Pola makan: cara mengatur jumlah porsi atau jenis makanan yang dikonsumsi tiap hari

Pola asuh: cara mendidik, membimbing, mendisiplinkan anak dan memperlakukan anak.

Pertumbuhan: hal (keadaan) tumbuh

Persepsi: anggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu;

Penyakit kronis: Penyakit yang telah berlangsung dalam waktu yang lama; menahun/ yang tidak sembuh-sembuh

Perilaku: tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan;

S

Sosialisasi: proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya;

Sikap: perilaku

Sosiokultural: berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat

Status gizi: keadaan nutrisi

V

Vitamin: zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk pertumbuhan dan perkembangan;

PROFIL PENULIS



Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom., Lahir di Mojokerto, 11 September 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Imu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011. Selanjutnya

melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Komunitas pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2012. Penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mulai tahun 1999-sekarang mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar maupun narasumber pada area keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik. Penulis tergabung dalam pengurus DPK PPNI, pengurus SPBI dan pengurus organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinahaggyraff@gmail.com

Motto: "Break free from the ordinary, explore the extraordinary."

"Never stop learning, growing, and evolving."

PROFIL PENULIS



Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes., Lahir di Lamongan, 15 Februari 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program S1 Ilmu Pendidikan pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2002, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2006.

Ambil Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh program Doktorat Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997- 1999 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, selanjutnya per 1 Maret 1999 sampai sekarang bekerja di UBS PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, dan sebagai nara sumber di berbagai instansi. Penulis juga aktif di organisasi profesi sebagai Sekretaris DPD PPNI Kab. Mojokerto dan pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizubspgni@gmail.com

Motto: "Life is a journey, so enjoy every step of the way" and "Make your life useful to others"

SINOPSIS BUKU

Indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) salah satunya adalah status gizi balita. Gizi berkontribusi lebih dari sepertiga dari semua kematian pada balita di dunia. Kekurangan gizi yang dialami balita akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita hingga dewasa dan bersifat irreversible.

Salah satu indikator keberhasilan Program Indonesia Sehat adalah terciptanya keluarga sehat, sehingga dalam pelaksanaan program, perlu adanya fokus pendekatan pada keluarga. Keluarga memiliki peranan yang penting bagi peningkatan dan pengawasan status gizi balita. Tugas kesehatan keluarga merupakan cerminan dari kemampuan keluarga dalam mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan keluarga. Pemahaman keluarga tentang pelaksanaan tugas kesehatan keluarga sangat diperlukan agar keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi balita secara tepat dan mencegah masalah gizi balita.

Hasil Penelitian terbukti tugas kesehatan keluarga efektif meningkatkan status gizi balita dengan pendekatan model Family Centered Nursing (FCN). Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga yang optimal berpengaruh pada peningkatan status gizi (berat badan normal) balita. Tenaga kesehatan terutama Perawat Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) diharapkan melakukan pendampingan dan pembimbingan pada keluarga agar keluarga mandiri dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga, sehingga status gizi balita bisa meningkat. Sumber-sumber pendukung dalam keluarga merupakan faktor yang meningkatkan kemandirian dalam keluarga, sehingga perawat perlu memaksimalkan potensi positif dalam keluarga.

--

Indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs (Sustainable Development Goals) salah satunya adalah status gizi balita. Gizi berkontribusi lebih dari sepertiga dari semua kematian pada balita di dunia.

Kekurangan gizi yang dialami balita akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita hingga dewasa dan bersifat irreversible.

Salah satu indikator keberhasilan Program Indonesia Sehat adalah terciptanya keluarga sehat, sehingga dalam pelaksanaan program, perlu adanya fokus pendekatan pada keluarga. Keluarga memiliki peranan yang penting bagi peningkatan dan pengawasan status gizi balita.

Tugas kesehatan keluarga merupakan cerminan dari kemampuan keluarga dalam mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan keluarga. Pemahaman keluarga tentang pelaksanaan tugas kesehatan keluarga sangat diperlukan agar keluarga bisa memenuhi kebutuhan gizi balita secara tepat dan mencegah masalah gizi balita.

Hasil Penelitian terbukti tugas kesehatan keluarga efektif meningkatkan status gizi balita dengan pendekatan model Family Centered Nursing (FCN).

Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga yang optimal berpengaruh pada peningkatan status gizi (berat badan normal) balita. Tenaga kesehatan terutama Perawat Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) diharapkan melakukan pendampingan dan pembimbingan pada keluarga agar keluarga mandiri dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga, sehingga status gizi balita bisa meningkat. Sumber-sumber pendukung dalam keluarga merupakan faktor yang meningkatkan kemandirian dalam keluarga, sehingga perawat perlu memaksimalkan potensi positif dalam keluarga.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-02-3



9

786347

139023